

Monograf

**EFEKTIVITAS PELATIHAN SKRINING
KESEHATAN MENTAL PERINATAL**

**DAMPAK TERHADAP PENGETAHUAN,
SIKAP, DAN PRAKTIK BIDAN**

Ana Pujianti Harahap
Aulia Amini
Cahaya Indah Lestari

Buku Monograf
EFEKTIVITAS PELATIHAN
SKRINING KESEHATAN MENTAL
PERINATAL:
DAMPAK TERHADAP
PENGETAHUAN, SIKAP, DAN
PRAKTIK BIDAN

Dr. Ana Pujianti Harahap, S.Si.T., M.Keb.

Aulia Amini, SST., M.Keb.

Cahaya Indah Lestari, SST., M.Keb.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Monograf
EFEKTIVITAS PELATIHAN SKRINING
KESEHATAN MENTAL PERINATAL:
DAMPAK TERHADAP PENGETAHUAN,
SIKAP, DAN PRAKTIK BIDAN

Dr. Ana Pujianti Harahap, S.Si.T., M.Keb.

Aulia Amini, SST., M.Keb.

Cahaya Indah Lestari, SST., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-623-89965-5-1

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal

Tiktok @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku monograf ini dapat tersusun. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelatihan bidan dalam pelaksanaan skrining Kesehatan Mental Perinatal pada ibu pascapersalinan. Masalah Kesehatan Mental Perinatal dimulai dari usia kehamilan 22 minggu sampai dengan satu tahun pascapersalinan. *World Health Organization* (WHO), 1 dari 5 wanita mengalami gangguan kesehatan mental selama masa perinatal, dengan risiko lebih tinggi pada masa pascapersalinan dibandingkan saat hamil. Di Indonesia, prevalensi PMH pada ibu pascapersalinan diperkirakan mencapai 50%-75%, yang lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain. Dampak yang diakibatkan yaitu penurunan kualitas hidup, risiko persalinan prematur, gangguan tumbuh kembang bayi, hingga risiko bunuh diri pada ibu.

Skrining terhadap Kesehatan Mental Perinatal sangat penting dilakukan untuk mencegah dampak buruk yang diakibatkan. Namun, banyak ibu pascapersalinan di Indonesia yang belum terskrining dengan baik, terutama karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam mengenali tanda-tanda PMH. Pelatihan bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, telah terbukti dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang skrining PMH, tetapi perubahan sikap dan praktik dalam melaksanakan skrining tersebut masih menjadi tantangan.

Monograf ini hadir untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya pelatihan skrining PMH bagi bidan, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik mereka dalam melaksanakan skrining pada ibu pascapersalinan. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi tenaga kesehatan, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental perinatal di Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Maret, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB 1 Pendahuluan.....	1
BAB 2 Kesehatan Mental Perinatal	6
A. Pengertian	6
B. Cakupan Gangguan Kesehatan Mental Perinatal.....	7
C. Faktor Risiko Kesehatan Mental Perinatal	11
D. Patofisiologi	15
E. Tanda Gejala	16
F. Dampak	17
G. Upaya Penanganan Gangguan Kesehatan Mental Perinatal	18
H. Program Layanan Terintegrasi.....	20
I. Peran Bidan dalam Kesehatan Mental Perinatal ...	21
BAB 3 Skrining.....	23
A. Definisi	23
B. Tujuan Skrining.....	24
C. Syarat Skrining/Prinsip Skrining	24
D. Skrining Kesehatan Mental Perinatal	26
BAB 4 Efektifitas Pelatihan Skrining Kesehatan Mental Perinatal terhadap Pengetahuan, Sikap dan Praktik Bidan	39
A. Efektivitas Pelatihan terhadap Pengetahuan Bidan tentang Skrining Kesehatan Mental Perinatal.....	39
B. Sikap Bidan Terhadap Kesehatan Mental Perinatal.....	44

C. Praktik Bidan dalam melakukan skrining Kesehatan Mental Perinatal	48
D. Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Praktik Bidan dengan Pelatihan Skrining Kesehatan Mental Perinatal	52
E. Strategi Pelatihan Untuk Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Praktik Bidan.....	54
BAB 5 Penutup.....	58
Daftar Pustaka	60
Profil Penulis.....	71

BAB 1

Pendahuluan

Kesehatan Mental Perinatal *atau Perinatal Mental Health* (PMH) adalah gangguan masalah kesehatan mental yang terjadi pada usia kehamilan 22 minggu sampai satu tahun pascapersalinan. Menurut *World Health Organization* (WHO) sebanyak 1(satu) dari 5 (lima) wanita mengalami masalah dalam kesehatan mental pada masa hamil dan pasca melahirkan (WHO, 2022) Setelah persalinan, ibu lebih sering mengalami postpartum blues yang tidak tertangani daripada ibu hamil, dengan perbandingan 1 banding 3. Pada wanita, sekitar 30 hingga 75 persen mengalami postpartum blues, dan sekitar 10 hingga 15 persen mengalami PMH.(O'Hara & Wisner, 2014)·(Kemenkes RI, 2019)·(Kemenkes RI., 2018) Hasil studi lainnya di tahun 2021 menunjukkan bahwa di wilayah Asia Tenggara ibu berisiko mengalami PMH sekitar 26-85%, sedangkan di Indonesia berkisar 50%-75% (Ali Mustofa et al., 2021). Gangguan kesehatan perinatal dapat berdampak pada ibu dan bayinya yaitu penurunan kualitas hidup, persalinan premature, menurunnya kadar oksitosin, gangguan tumbuh kembang bayi, dan kejadian bunuh diri. Skrining yang dilakukan sejak dini dapat menurunkan dampak yang ditimbulkan oleh PMH.(Simcock et al., 2018)·(Sadat et al., 2014)·(Daehn et al., 2022)

Kejadian gangguan kesehatan mental perinatal tidak hanya berdampak pada ibu pascapersalinan namun juga kepada bayi yang dilahirkan. Dampak yang terjadi pada bayi antara lain risiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan bayi, serta menurunnya kadar oksitosin yang berpotensi mengurangi asupan nutrisi pada bayi. Hasil studi menunjukkan adanya penurunan rata-rata kadar oksitosin pada ibu dengan gangguan kesehatan mental perinatal sebesar 60,71 pg/ml. (Deti Siti Nurdiati, 2020)(Sugeng, 2013)(Kemenkes RI., 2018) gangguan kesehatan mental perinatal yang berkepanjangan pada ibu pascapersalinan dapat mengurangi kualitas interaksi ibu dengan bayi, seperti pemberian ASI dan perhatian emosional, yang berdampak pada perkembangan mental bayi, termasuk meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan perilaku di masa depan.

Selain itu, jika tidak terobati dapat menyebabkan persalinan prematur, berat badan lahir rendah, gangguan perilaku bayi, hingga meningkatkan risiko bunuh diri. Ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental perinatal pasca persalinan juga cenderung menyebabkan peningkatan gangguan motorik halus pada bayi.(Simcock et al., 2018)(Sadat et al., 2014)(Daehn et al., 2022) Pada tahun 2012, WHO memperkenalkan *International Classification of Diseases for Maternal Mortality* (ICDMM), yang pada 2018 direkomendasikan untuk mengklasifikasikan bunuh diri dalam kehamilan dan hingga 12 bulan pasca persalinan sebagai kematian kebidanan langsung di Afrika. (Howard & Khalifeh, 2020) Bunuh diri adalah penyebab kematian kedua bagi wanita pada periode postpartum, yang menyebabkan 20% kematian selama tahun pertama setelah kelahiran(Van Niel & Payne, 2020). Kematian lebih sering terjadi pada masa tahun kedua pasca persalinan pertama.(Howard & Khalifeh, 2020).

Faktor risiko yang mempengaruhi gangguan kesehatan mental perinatal pada ibu berdasarkan hasil studi diantaranya yaitu faktor kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual.(Sandy et al., 2020). Kekerasan seksual dari pasangannya akan berpotensi 2,04 kali berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan mental perinatal (Zhang et al., 2019). Kejadian PMH juga dapat terjadi pada ibu yang mengalami *intimate partner violence* (IPV)(Islam et al., 2017). Selain itu faktor risiko lainnya yaitu faktor riwayat sebelumnya. Riwayat sebelumnya diantaranya yaitu riwayat obstetrik, dan riwayat kesehatan mental sebelumnya yang didapatkan pada masa kanak-kanak, remaja serta pada masa hamil. Riwayat obstetrik yang dapat mempengaruhi PMH terdiri dari jenis persalinan, jumlah anak, dan trauma persalinan. Jenis persalinan dengan *Sectio Caesarea (SC) Emergency* akan mempengaruhi kesehatan mental ibu pasca persalinan dan jumlah anak yang lebih dari dua.(Roubinov et al., 2022)(Peng et al., 2021)(van Steijn et al., 2021)(Badiya et al., 2020). Ibu yang sebelumnya pernah mengalami PMH saat hamil akan berisiko 4,25 kali mengalami PMH kembali pada masa pasca persalinan.(Peng et al., 2021). Peningkatan risiko pasca persalinan memungkinkan akan memperparah penyakit kejiwaan sebelumnya pada wanita yang memiliki riwayat penyakit kesehatan mental.(Howard & Khalifeh, 2020).

Faktor lain yang juga berkontribusi pada kejadian PMH selama periode hamil, persalinan dan pascapersalinan yaitu: demografi, kerawanan pangan, kondisi kesehatan fisik, kepuasan menyusui dan situasi sosial yang mengancam jiwa. Ibu dengan PMH pascapersalinan banyak ditemukan pada ibu yang hamil di usia kurang dari 18 tahun dan memiliki riwayat penyakit medis. Kejadian PMH pascapersalinan juga banyak ditemukan dalam situasi sosial yang mengancam jiwa, dimana salah satu contohnya

yaitu pada masa COVID-19, dimana pada periode tersebut terjadi peningkatan kasus PMH pada ibu hamil.(Garman et al., 2019)(Yonemoto et al., 2021). Rendahnya dukungan sosial pada ibu pascapersalinan dari berbagai pihak juga merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya PMH(Garman et al., 2019)(Peng et al., 2021)(Comrie-Thomson et al., 2022).

Ibu pasca persalinan yang tinggal dengan keluarga besar dan tidak mendapatkan dukungan keluarga berisiko akan mengalami PMH. (Lindayani & Marhaeni, 2019)(Pilav et al., 2022)(Comrie-Thomson et al., 2022). Selain itu dukungan tenaga kesehatan terhadap PMH akan memberikan dampak yang positif terhadap perawatan layanan kesehatan (Branquinho et al., 2022). Dukungan tenaga kesehatan yang diberikan dalam bentuk skrining deteksi dini memiliki peran penting untuk mengurangi dampak negatif PMH. Di sisi lain, skrining deteksi dini juga dapat memberikan intervensi lebih awal yang mencakup dukungan emosional bagi ibu pascapersalinan.(Kemenkes RI., 2018)(Deti Siti Nurdianti, 2020)

Selama ini ibu pasca persalinan yang mengalami gangguan kesehatan mental perinatal kurang terskrining dengan baik. Hasil studi menunjukkan bahwa ibu pasca persalinan yang tidak terskrining dengan baik tidak menerima perawatan yang memadai.(Cantwell, 2021) Banyak profesional kesehatan yang tidak mampu mengenali tanda gejala PMH. (Cena et al., 2020) Dari hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi skrining salah satunya yaitu tenaga kesehatan. Faktor yang terdapat pada tenaga kesehatan yaitu pengetahuan, sikap dan praktik pelaksanaan skrining. (Gimeno Garca, 2012)(Nithianandan et al., 2016) Adanya pelatihan sudah terbukti efektif dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang. Secara teori keterampilan merupakan penerapan

pengetahuan secara praktis, dan didukung dengan adanya keinginan atau sikap dalam melakukan keterampilan tersebut (Soekidjo Notoatmodjo, 2014).

WHO merekomendasikan bahwa skrining PMH pada ibu pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh PMH. Tenaga kesehatan terlatih yaitu bidan, perawat atau dokter. (WHO, 2022) (Maria et al., 2023) (World Health Organization, 2017) Meskipun banyak penelitian sebelumnya melakukan penelitian tentang skrining PMH, namun masih terbatas yang mengeksplorasi terkait pelatihan skrining PMH dengan cakupan kecemasan dan depresi pada ibu pascapersalinan. Pentingnya pelatihan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik bidan terkait PMH menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Setelah mengidentifikasi kesenjangan tentang skrining PMH pada ibu pascapersalinan dari uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik bidan terkait pelaksanaan skrining gangguan kesehatan mental perinatal pada ibu pascapersalinan.

BAB 2

Kesehatan Mental Perinatal

A. Pengertian

Gangguan Kesehatan Mental Perinatal merupakan masalah kejiwaan yang terjadi selama kehamilan dan selama satu tahun setelah persalinan. Gangguan ini termasuk depresi, kecemasan, dan psikosis pasca persalinan, yang biasanya berubah menjadi gangguan bipolar.(WHO, 2022) Gangguan kesehatan mental ini adalah salah satu morbiditas kehamilan yang paling umum, dan dapat memberikan pengaruh yang penting bagi kematian ibu, serta memberikan dampak yang merugikan bagi neonatal, bayi dan anak-anak.(Howard & Khalifeh, 2020)

Depresi dan kecemasan perinatal sering terjadi, dengan tingkat prevalensi depresi mayor dan minor hingga 20% selama kehamilan dan 3 bulan pertama pascapersalinan. Meskipun tidak sebanyak gangguan afektif setelah persalinan, *postpartum blues* adalah gejala yang umum. Fungsi wanita terganggu dan perkembangan anak terganggu karena gangguan psikiatri saat hamil.(O'Hara & Wisner, 2014) Peningkatan risiko pasca melahirkan ini ditemukan di antara wanita baik dengan dan tanpa penyakit kejiwaan sebelumnya, tetapi lebih banyak ditemukan pada wanita dengan gangguan suasana hati parah yang sudah ada sebelumnya (Howard & Khalifeh, 2020).

B. Cakupan Gangguan Kesehatan Mental Perinatal

1. Kecemasan

Kecemasan merupakan perasaan yang ditandai dengan munculnya kekhawatiran atau takut akan sesuatu. Prevalensi gejala kecemasan pada ibu pasca persalinan didapatkan sebesar 22,9%. Hasil studi lainnya menyebutkan bahwa setidaknya ibu pasca persalinan akan mengalami kecemasan setidaknya satu kali selama masa pasca persalinan. (Dennis et al., 2017); (Emily J Fawcett et al., 2019) Cakupan kecemasan terdiri dari *Anxiety Disorder*, *Generalized Anxiety Disorder (GAD)*, *Panic disorder*, dan *Phobias*. Angka kejadian fobia dari hasil studi 4,8% dengan gangguan yang muncul diperkirakan 16.7% s/d 25,4%. *Anxiety Disorder (AD)* merupakan kecemasan yang terjadi pada ibu pasca persalinan secara berlebihan. (Elena Ali, 2023) AD memiliki karakteristik yang sama dengan kecemasan umum lainnya namun berfokus pada kecemasan ibu pasca persalinan terhadap kelainan janin, perasaan ketidakmampuan sebagai seorang ibu, kematian janin dan cemas memiliki sedikit dukungan. (Percudani et al., 2022)

Generalized Anxiety Disorder (GAD) merupakan suatu kondisi kecemasan yang berlebihan yang terjadi lebih banyak selama 6 bulan disertai dengan kelelahan, mudah tersinggung, konsentrasi buruk, ketegangan otot dan gangguan tidur.(Percudani et al., 2022) Prevalensi kejadian untuk GAD diperkirakan 1,3% s/d 4,1%. (Emily J Fawcett et al., 2019) *Panic disorder* merupakan kecemasan yang terjadi secara tiba-tiba dan berlebihan. Setidaknya dalam 1 bulan terjadi dua kali. Gejala kecemasan berupa kecemasan fisik dan psikologis. Prevalensi kejadian kisaran 2% s/d 4%.(Percudani et al., 2022) Sedangkan phobia merupakan ketakutan atau

kecemasan yang hebat dan bertahan lama. Periode kejadian selama masa perinatal yaitu 1,6%-19,9%.⁶⁵(Janice H Goodman et al., 2014)(Emily J Fawcett et al., 2019)Pada kondisi fobia yang parah disebut tokofobia. Ibu dengan tokofobia jika tidak tertangani akan mengalami depresi berat. (Percudani et al., 2022)

2. Depresi

Depresi postpartum adalah masalah psikologis yang agak berat yang menyebabkan ibu mengalami kesulitan tidur atau tidak bisa tidur. Bisa terjadi antara dua minggu dan satu tahun setelah persalinan.(Layliana & Septi Indah Permata Sari, 2021) Hasil studi menunjukkan bahwa pada ibu hamil yang mengalami depresi sebesar 11,09%, dan pada ibu pasca persalinan 12,5%.(Bante et al., 2021b)(de Avilla et al., 2020) Depresi postpartum, atau trias depresi, adalah gejala yang paling umum, yaitu: mengalami kesulitan tidur, merasa sedih, hilangnya motivasi, dan merasa tidak bermanfaat.

Tanda gejala depresi diantaranya yaitu sering menangis ketika melihat bayi, merasa masa depan yang buruk, sedih, tidak semangat, gelisah, murung, merasa tidak bahagia, nafsu makan menurun, mengalami gangguan makan, gangguan tidur, merasa sudah tidak berguna, tidak bisa konsentrasi, tidak bersedia merawat bayinya, dan pernah berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau bayinya. (Kemenkes RI, 2019)(Layliana & Septi Indah Permata Sari, 2021).

Adapun jenis-jenis depresi postpartum sebagai berikut:

a. Depresi ringan dan sedang

Sekitar 10% sampai dengan 15% ibu yang melahirkan mengalami depresi ringan. Gejala awal depresi postpartum ringan, seperti perasaan tidak mampu

melakukan koping dan tertekan oleh kewajiban menjadi ibu, yang dapat menyebabkan gangguan tidur, dikenal sebagai depresi postpartum. Perasaan seperti sedih, tidak mampu, tidak berharga, kehilangan nafsu makan, harga diri rendah, dan penurunan suasana hati yang berkelanjutan serta hilangnya spontanitas dan kegembiraan biasanya muncul. Pada saat ini, ibu yang baru melahirkan belum mempertimbangkan untuk membahayakan dirinya dan anaknya. Penanganan dengan konseling dan kerjasama kolaborasi dengan psikolog.

b. Depresi berat

Diperkirakan kejadian depresi postpartum berat 3-5% ibu pasca persalinan akan mengalaminya. Depresi berat dapat muncul segera setelah persalinan. Tampaknya ibu yang mengalami depresi berat mengalami kesedihan dan kesedihan yang mendalam. Pada titik ini, ibu yang baru melahirkan sudah mempertimbangkan untuk membahayakan dirinya sendiri dan anaknya. Pada awalnya, gejala depresi berat tidak terlihat atau tidak terlihat, dan mulai muncul secara bertahap pada dua hingga tiga minggu pertama setelah persalinan. Penanganan dengan rujukan rawat inap di rumah sakit. Terapy psikologis dari psikiater, kolaborasi pemberian anti depresan, dan tidak dianjurkan rawat gabung dengan bayinya.

3. Psikosis

Puerperal *psychosis* merupakan gejala psikotik ibu pasca persalinan yang dapat menyakiti diri sendiri, yaitu delusi untuk melakukan tindakan bunuh diri dan pembunuhan pada bayi. Ibu pasca persalinan yang mengalami psikosis biasanya memiliki diagnosis yang konsisten dengan depresi

bipolar, mania, atau keadaan campuran, dengan ciri-ciri psikotik.(Dazzan et al., 2018) *Psychosis* Kebanyakan terjadi dalam minggu pertama setelah persalinan dan jarang terjadi sebelum 3 hari setelah persalinan, kebanyakan terjadi sebelum 16 hari setelah persalinan. *Psychosis* pada ibu pasca persalinan terjadi kurang lebih 2-3 per 1000 kelahiran dan memerlukan penatalaksanaan psikiatrik (kejiwaan). *Psychosis* dianggap sebagai gangguan jiwa paling parah yang terjadi setelah persalinan, meskipun jarang terjadi. (Layliana & Septi Indah Permata Sari, 2021)

4. *Stressor/trauma-related disorder dan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*

Stres traumatic yang terjadi pada ibu pasca persalinan merupakan respon terhadap trauma yang pernah dialami oleh ibu sebelumnya. Stres traumatic dapat memicu masalah kesehatan psikologis dalam jangka panjang. (Percudani et al., 2022)Trauma berdampak seumur hidup, dan sewaktu waktu akan muncul kekambuhan kembali. Pada kasus ibu pasca persalinan trauma kesehatan mental yang pernah dialami oleh ibu masa kanak-kanak, remaja, kehamilan dan persalinan kemungkinan akan mempengaruhi kesehatan mental.(Percudani et al., 2022)(Peng et al., 2021)

5. Gangguan makan (eating disorders)

Eating disorders (ED) merupakan gangguan makan yang terjadi pada ibu pasca persalinan. Dari hasil study ditemukan bahwa terdapat hubungan dengan dampak buruk yang akan diakibatkan terhadap ibu dan bayinya. Adanya ED ditandai dengan adanya berat badan rendah, pembatasan asupan makanan, dan hambatan pertumbuhan.(Hunna J Watson

Stephanie Zerwas et al., 2017)(Percudani et al., 2022)(Treasure et al., 2020)

6. *Sleep Disorders*

Gangguan tidur merupakan salah satu faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan mental selama masa pasca persalinan. Perubahan psikologi yang terjadi pada ibu pasca persalinan akan mempengaruhi durasi tidur, kualitas tidur, dan pola tidur. Sehingga selama masa pasca persalinan tidur ibu akan terganggu. *Sleep Disorders* pada ibu pasca persalinan yang cenderung lama dan menetap memiliki hubungan dengan kejadian depresi dan psikosis. (Percudani et al., 2022)(Elisabeth Hertenstein Bernd Feige et al., 2019)

C. **Faktor Risiko Kesehatan Mental Perinatal**

Dalam Teori *Blum* yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat (dikenal sebagai "Teori Blum") digunakan untuk mengevaluasi berbagai faktor risiko yang berkontribusi pada PMH. Lingkungan, gaya hidup (perilaku manusia), keturunan, dan pelayanan kesehatan adalah empat komponen utama yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Menurut Blum, kesehatan individu atau populasi tidak dapat ditentukan oleh satu jalur; sebaliknya, kesehatan ditentukan oleh interaksi kompleks dari berbagai elemen di atas. (Purnama, 2017)

Menurut *Blum*, dari keempat komponen tersebut, lingkungan menjadi yang paling penting dan paling besar berdampak terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Gaya hidup dan keturunan menjadi faktor kedua yang berdampak terhadap kesehatan, dan pelayanan kesehatan memiliki dampak yang relatif kecil terhadap kesehatan individu dan masyarakat. (Purnama, 2017).

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental perinatal yaitu:

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan dalam teori Blum di bagi menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik yaitu yang berkaitan dengan polusi udara, kontaminasi makanan dan air, radiasi, senyawa beracun, limbah atau sampah dan perubahan habitat.(Purnama, 2017) Dalam hal ini faktor fisik yang mempengaruhi PMH pada ibu pasca persalinan yaitu dalam kondisi yang mengancam jiwa.(WHO, 2022) Salah satunya yaitu kondisi pada saat COVID-19, di mana penularan virus melalui *mikrodroplet* kecil yang ditularkan melewati udara. (Adrian Covaci, 2020) Dari hasil study terkait tentang COVID-19 menyatakan bahwa pada masa COVID-19 sebagian besar ibu pasca persalinan lebih dari 50% mengalami kecemasan sedang terhadap sindrom pernafasan akut COVID-19. Terdapat hubungan korelasi antara peningkatan kecemasan ibu terkait COVID-19 dengan peningkatan kejadian PMH (Hübner et al., 2022)

Faktor lingkungan sosial dalam teori Blum yaitu faktor hubungan status sosio ekonomi. Dalam hal ini faktor risiko yang mempengaruhi PMH yaitu faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. (Garman et al., 2019) Faktor sosial yang paling mempengaruhi PMH yaitu dukungan yang diberikan oleh suami. Kurangnya dukungan suami dapat menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran pada ibu.(MacMillan et al., 2020) Tidak adanya dukungan suami berupa kekerasan yang dilakukan oleh suami juga dapat menjadi faktor risiko PMH. Dalam hal ini riwayat pernikahan dan tipe keluarga pada ibu pasca persalinan dapat menjadi faktor risiko terjadinya PMH.(Badiya et al., 2020) Jika ditinjau dari faktor ekonomi

dari hasil studi, ditemukan bahwa ibu dengan penghasilan yang lebih rendah lebih berisiko mengalami penyakit PMH.(Garman et al., 2019) Namun hal ini tidak sejalan dengan tingkat pendidikan secara teori yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan rendah berbanding lurus dengan tingkat pendidikan rendah.(Purnama, 2017) Dari hasil studi ibu pasca persalinan dengan pendidikan tinggi lebih berisiko dari pada ibu dengan pendidikan rendah.(Badiya et al., 2020)

2. Faktor gaya hidup (perilaku manusia)

Gaya hidup yang berisiko memengaruhi kesehatan.(Purnama, 2017) Perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan fisik, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. (Soekidjo Notoatmodjo, 2014) Pada ibu pasca persalinan riwayat psikologi merupakan faktor internal dari ibu pasca persalinan yang berkaitan dengan emosional. Faktor riwayat psikologi sebelumnya dapat mempengaruhi kesehatan mental pada masa pasca persalinan.

Berdasarkan hasil studi faktor kesehatan mental riwayat sebelumnya yaitu baik masa hamil maupun masa anak-anak menjadi faktor risiko terjadinya PMH pada ibu pascapersalinan. Riwayat trauma masa kanak-kanak akan saling berkaitan dan terintegrasi dengan kesehatan mental pada masa hamil dan berdampak pada ibu pascapersalinan serta anak yang dilahirkan. Kondisi Ibu yang sebelumnya sudah pernah mengalami masalah kesehatan mental cenderung akan menderita dengan tekanan adaptasi

pencapaian peran sebagai ibu. (Roubinov et al., 2022)(Peng et al., 2021)

3. Faktor keturunan/genetik

Faktor keturunan atau genetik merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang terhadap jenis penyakit tertentu. Penyakit medis yang diderita oleh ibu dapat diperoleh melalui keturunan seperti hemofilia, hipertensi, jantung, kelainan bawaan, albino dan lain lain.(Purnama, 2017) Ibu yang mengalami penyakit medis dapat menimbulkan komplikasi saat persalinan atau pasca persalinan. Penyakit medis yang diderita oleh ibu pasca persalinan dapat meningkatkan risiko terjadi PMH di bandingkan dengan ibu yang tidak memiliki penyakit medis. (Bante et al., 2021a)

Ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan risiko atau komplikasi medis yang dapat terjadi pada ibu yang baru melahirkan, seperti perdarahan pasca persalinan, infeksi pasca persalinan, lochea berbau busuk, dan sub involusi uteri, nyeri di perut dan pelvis, pusing dan lemas yang berlebihan, sakit kepala, nyeri epigastrik, dan penglihatan kabur, suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat Celcius, payudara berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit, kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama, rasa sakit, merah, lunak, dan pembengkakan di wajah dan ekstremitas, demam, muntah, dan rasa sakit saat berkemih.(Kemenkes RI., 2018)

4. Faktor pelayanan kesehatan

Faktor pelayanan kesehatan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di nilai dari seberapa jauh pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan rumah sakit yang

memadai, jangkauan obat yang mudah, teknologi peralatan yang canggih, tenaga kesehatan yang handal di mana semuanya harus dalam kondisi siap dan memadai untuk memfasilitasi masyarakat. (Purnama, 2017) Pada ibu pasca persalinan adanya dukungan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dapat mengurangi terjadinya PMH. Dukungan tenaga kesehatan berupa skrining yang dilakukan sejak dini dapat membantu ibu pasca persalinan untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan yang tepat.(Stevenson et al., 2020) Namun kurangnya pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan tentang PMH dapat menjadi hambatan untuk bisa memberikan pelayanan yang tepat.(Gureje et al., 2015)(Dyer et al., 2019)

D. Patofisiologi

Kadar hormon human chorionic gonadotropin (hCG), estrogen, dan progesteron turun secara signifikan dalam dua minggu pertama setelah plasenta lahir. Turunnya kadar progesteron secara cepat dianggap sebagai penyebab depresi postpartum. Namun, sensitivitas reseptor dopamin meningkat segera setelah penurunan estrogen, yang menyebabkan episode psikotik postpartum pada wanita bipolar. Selain itu, salah satu penemuan biologis yang sering dikaitkan dengan gangguan mood adalah disregulasi aksis *hypothalamic-pituitary-adrenocortical* (HPA). Aksis HPA berubah secara signifikan pada minggu pertama setelah persalinan. Segera setelah persalinan, reseptor *corticotropin releasing hormone* (CRH) di hipotalamus berkurang, yang mengakibatkan respons *adrenocorticotrophic hormone* (ACTH) dan pelepasan kortisol yang lebih sedikit. Dalam enam minggu setelah persalinan, respons ini kembali normal.(Saba Mughal; Yusra Azhar; Waquar Siddiqui., 2022)(Veerle Bergink, 2012)

Serangan awal yang terjadi pada ibu pasca persalinan ditandai dengan adanya gejala awal baby blues yang ditemukan berupa cepat tersinggung, mudah marah dan akan terjadi kecemasan. Masa ini akan berlangsung selama 3-5 hari. Apabila masa ini tidak tertangani maka akan berkembang menjadi terjadinya kecemasan dan depresi postpartum yang berlangsung dalam satu tahun pasca persalinan dengan gejala yang ditimbulkan suasana hati rendah, perasaan rasa bersalah, gangguan perasaan ikatan dengan anak. Dan selanjutnya akan berkembang menjadi psikosis berupa agitasi, mudah tersinggung, suasana hati euforia, depresi, delusi, halusinasi, kebingungan, dan gejala kognitif. (Nguyen et al., 2022)(Veerle Bergink, 2012)(Pawluski et al., 2017)

E. Tanda Gejala

Gangguan kesehatan mental perinatal dapat dideteksi dengan skrining kehamilan dan masa nifas atau pascapersalinan. Gejala awalnya termasuk kecemasan, depresi, dan psikosis. Untuk kesejahteraan ibu dan bayinya, diagnosis dan pengobatan gangguan kejiwaan selama kehamilan sangat penting. (O'Hara & Wisner, 2014) Berikut merupakan tanda gejala PMH : (WHO, 2022) yaitu merasa sedih, tidak bahagia, kurang bertenaga, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu, mempunyai perasaan khawatir yang terlalu berlebihan, terdapat gangguan makan dan tidur, sulit untuk dapat berkonsentrasi, kesulitan dalam mengambil suatu keputusan, merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan, merasa diri tidak berguna, dan merasa akan terjadi sesuatu hal yang buruk baik pada diri sendiri atau bayinya.

F. Dampak

1. Sebagai penyebab utama kematian ibu di negara maju adalah bunuh diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bunuh diri merupakan penyebab utama kematian bayi selama kehamilan. Sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh bunuh diri. Resiko terjadinya bunuh diri pada masa perinatal terjadi pada ibu yang mengalami PMH. (Howard & Khalifeh, 2020)
2. Peningkatan risiko persalinan, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan *Intra Uterine Grow Retardation* (IUGR). Dari hasil studi didapatkan bahwa BBLR lebih banyak ditemukan pada ibu pasca persalinan yang mengalami PMH. Hal ini didukung oleh faktor risiko PMH seperti kekerasan dalam rumah tangga dan penyakit medis penyerta yang dialami ibu. (Howard & Khalifeh, 2020)
3. Menunjukkan hubungan dan ikatan, ibu yang mengalami *postpartum blues* memiliki kadar oksitosin yang lebih rendah daripada ibu yang tidak mengalaminya. (Sugeng, 2013) Hormon oksitosin berfungsi untuk membantu proses pengeluaran Air Susu Ibu (ASI) saat ibu menyusui, di mana saat pemberian ASI dapat membentuk *bonding attachment* pada ibu. Oksitosin dapat menurunkan kadar kortisol, yang menghasilkan efek relaksasi, penurunan tekanan darah, kecemasan, dan perilaku keibuan yang lebih baik. (Kemenkes RI., 2018)
4. Gangguan kesehatan mental perinatal dapat menyebabkan rendahnya keinginan ibu untuk merawat bayinya sehingga mengakibatkan ikatan keibuan yang buruk atau tidak ada dengan bayi. Selain itu dapat meningkatkan tingginya stress pengasuhan, dan peningkatan risiko gangguan perilaku dan kognisi pada anak-anak. (Daehn et al., 2022)

5. Penurunan Kualitas Hidup

Dari hasil studi didapatkan bahwa ibu yang mengalami PMH akan terjadi penurunan kualitas hidup pada dua bulan pertama pasca persalinan. Ibu yang mengalami PMH setelah persalinan mengalami penurunan kualitas hidup dan ketidakmampuan untuk merawat pasangannya, bayinya, dan dirinya sendiri.(Sadat et al., 2014)

6. Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan bayi Hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi yang diidentifikasi ibunya tidak mengalami PMH memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan bayi yang memiliki ibu dengan PMH.(Simcock et al., 2018)

G. Upaya Penanganan Gangguan Kesehatan Mental Perinatal

Menurut WHO terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan mental perinatal yaitu : (WHO, 2022)

1. Adanya dukungan dari lingkungan sekitar

Dukungan dari lingkungan sekitar dapat diperoleh dengan cara mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap adanya gangguan kesehatan mental perinatal. Selain itu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap PMH. Beberapa bentuk tidak adanya dukungan dan kepedulian sosial terhadap kesehatan mental perinatal yaitu : adanya tindakan pelecehan yang dilakukan secara fisik (memukul atau menampar, memaki, menampar, berteriak, dan mendorong), pemberian layanan kesehatan yang kurang baik, diskriminasi terhadap pasien dengan gangguan kesehatan mental perinatal, menunjukkan sikap tidak empaty dan ketidakpedulian, dan melakukan tindakan penahanan (missal penahanan pasien yang dilakukan

dirumah sakit karena alasan belum memenuhi biaya rumah sakit).

2. Promosi dan pencegahan

Promosi yang diberikan dalam bentuk psikoedukasi yang diberikan oleh tenaga terlatih. Edukasi yang diberikan tidak hanya kepada ibu pasca persalinan namun pada suami dan anggota keluarga, untuk dapat memberikan dukungan sosial. Dengan adanya promosi kesehatan diharapkan dapat memberikan tindakan pencegahan lebih awal sebelum terjadi PMH. Tindakan pencegahan pada PMH juga dapat dilakukan dengan mengenali PMH sejak dini, dengan menggunakan penyaringan peralatan yang valid atau skrining yang tepat. Skrining dapat dikelola oleh komunitas terlatih seperti tenaga kesehatan, bidan, perawat atau pemberi pelayanan KIA lainnya. Edinburgh Post-natal Depression Scale (EPDS) merupakan skrining yang direkomendasikan oleh WHO untuk mendeteksi sejak dini terhadap PMH.

3. Pemberian layanan perawatan kesehatan

Dalam memberikan layanan perawatan PMH tidak hanya diberikan pada kondisi PMH sudah mengalami gangguan, namun pada kondisi masalah PMH ringan seperti Baby Blues atau Postpartum Blues harus mendapatkan layanan perawatan kesehatan. Pada gangguan masalah PMH berat penatalaksanaan dilakukan dengan tindakan rujukan, dan pada masalah PMH ringan dengan pemberian edukasi. Pendekatan perawatan yang diberikan secara bertahap dan *continue*.

4. Penekanan pada system manajemen kesehatan

Dalam mengatasi PMH latihan mindfulness, relaksasi dan latihan pernapasan dapat membantu. Latihan manajemen stres dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam kelompok pendukung, kelas pengasuhan anak atau kelas

antenatal jika tersedia dan fasilitator dilatih untuk menyampaikannya.

H. Program Layanan Terintegrasi

1. Perencanaan

Untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan, tahap perencanaan memerlukan analisis kebutuhan sumber daya manusia (SDM), dana, dan elemen lainnya. Perencanaan harus mempertimbangkan adat istiadat dan kebutuhan ibu setelah persalinan

2. Persiapan

Pada tahap persiapan perlu mengidentifikasi perawatan yang tepat dan strategi rujukan. Perawatan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk dukungan dari lingkungan sekitar dengan memperhatikan budaya setempat. Selain itu perlu mengidentifikasi tempat dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung perawatan PMH

3. Pelaksanaan

Di tahapan pelaksanaan perlu memastikan bahwa ibu pasca persalinan menerima dukungan PMH yang disesuaikan dengan kebutuhan. Memberikan promosi kesehatan dan pencegahan berupa pemberian edukasi, skrining dan penanganan yang tepat

4. Evaluasi tindak lanjut

Evaluasi pada PMH terintegrasi yaitu menilai kemajuan dari target layanan. Kesesuaian target dari hasil yang sudah dicapai berdasarkan kinerja dari tenaga kesehatan dan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk penyandang dana dari perawatan kesehatan mental perinatal.

I. Peran Bidan dalam Kesehatan Mental Perinatal

Kebutuhan dukungan sosial, dan psikis orang tua adalah bagian dari aspek yang penting untuk keberhasilan asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui, sehingga dapat terhindar dari penyulit atau komplikasi kebidanan. Tiap ibu pascapersalinan atau orang tua, sudah dapat mempersiapkan kehamilan, persalinan dan pascapersalinan untuk mempersiapkan diri sebagai orang tua dengan memberikan pendidikan kesehatan dan KIE postpartum khususnya terkait kesehatan mental perinatal yang dapat mempengaruhi janin atau bayi yang dilahirkan. (Kemenkes RI., 2018), (Ana Pujiанти Harahap et al., 2022)(Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 2021).

Aktivitas edukasi yang diberikan kepada ibu pascapersalinan yang berhubungan dengan kesehatan mental perinatal meliputi pemberian edukasi pola istirahat dan tidur yang adekuat pada masa nifas, perawatan bayi, dan menyusui bayi. Berikan penjelasan tentang pola istirahat yang normal pada ibupascapersalinan. Perawatan keterampilan bayi meliputi perawatan tali pusat, *personal hygiene*, suhu ruangan bayi yang dipertahankan pada kondisi yang hangat, respon terhadap bentuk tangisan bayi, pola tidur dan posisi tidur. Teknik menyusui yang benar sudah mulai diberikan sejak hamil berkaitan dengan pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif serta mempertahankan laktasi, teknik memerah, dan menyimpan ASI pada ibu yang bekerja. (Kemenkes RI., 2018)

Selain itu aktivitas edukasi yang perlu diberikan kepada ibu pascaperslinan berupa pendidikan kesehatan tentang emosi dan seksual meliputi efek kehadiran bayi dirumah, perubahan peran dan tanggungjawab, hubungan dengan pasangan dan keluarga, kecemburuan saudara kandung (*sibling rivalry*),

adaptasi psikologis, mengatur hubungan seksual, dan antisipasi terjadinya dispareunia. (Soep, 2011)

Berdasarkan beberapa hasil studi faktor risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan skrining yaitu faktor demografi, pendapatan, tingkat pendidikan, asuransi kesehatan, calon peserta yang akan di skrining, tenaga kesehatan atau system layanan kesehatan dan kebijakan program. Faktor yang terdapat pada calon peserta dan tenaga kesehatan berupa pengetahuan dan sikap. Terdapat hubungan antara tenaga kesehatan dan system layanan kesehatan dengan praktik pelaksanaan skrining. Hal lainnya yaitu adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan skrining, kurangnya pelatihan dan kesadaran dari tenaga kesehatan, kurangnya penggunaan alat penilaian skrining, dan kurangnya pelaksanaan skrining yang dilakukan secara rutin. (Premji et al., 2021),(Kingston et al., 2014),(Nwoke et al., 2023)

BAB 3

Skrining

A. Definisi

Skrining merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap sekelompok orang untuk memisahkan orang yang sehat dari orang yang mempunyai keadaan patologis yang tidak terdiagnosis atau memiliki risiko tinggi terhadap suatu penyakit. Skrining adalah proses yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi penyakit – penyakit yang tidak diketahui atau tidak terdeteksi dengan menggunakan berbagai alat test atau uji yang dapat diterapkan secara tepat dalam sebuah skala yang besar.(Erna Veronika, 2023) Skrining dapat juga dikatakan sebagai suatu proses penapisan di mana seseorang dievaluasi dan disaring berdasarkan kriteria gejala dari riwayat epidemiologis untuk menentukan apakah pasien termasuk termasuk kedalam kategori yang dicurigai. (Kemenkes, 2021) Skrining gangguan kesehatan mental perinatal dilakukan pada semua ibu hamil dan ibu dalam satu tahun pasca persalinan yang sudah melalui tahapan penapisan awal untuk diskruining.(Layliana & Septi Indah Permata Sari, 2021)

B. Tujuan Skrining

Terdapat beberapa tujuan dilakukan skrining menurut (Erna Veronika, 2023) yaitu:

1. Menemukan orang yang menderita penyakit sedini mungkin untuk memperbaiki prognosis karena pengobatan dapat dilakukan sebelum penyakit tampak klinis, memungkinkan intervensi lebih awal untuk mengurangi kematian dan penderitaan.
2. Sebagai pencegahan penyakit di kalangan masyarakat.
3. Mendidik dan membiasakan masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin.
4. Memberikan pengetahuan dan gambaran kepada petugas kesehatan tentang sifat penyakit dan untuk selalu waspada mengamati gejala dini.
5. Mendapatkan informasi epidemiologis yang bermanfaat bagi klinis dan peneliti.

C. Syarat Skrining/Prinsip Skrining

Beberapa prinsip skrining menurut (I Wayan Gede Artawan Eka Putra et al., 2016)(Erna Veronika, 2023):

1. Penyakit yang dituju adalah masalah kesehatan yang sangat umum dan mengancam jiwa.
2. Ketersediaan obat yang mungkin untuk memungkinkan pengobatan bagi mereka yang dinyatakan berisiko positif berdasarkan hasil tes, serta biaya pengobatan yang rendah
3. Ekonomis

Tes atau kuesioner yang digunakan bernilai ekonomis, yang berarti biaya yang diperlukan untuk melakukan skrining lebih rendah dari yang biasa digunakan. Ekonomis bagi masyarakat dengan tersedianya biaya untuk diagnosis dan pengobatan.

4. Cepat

Proses skrining yang digunakan tidak membutuhkan waktu yang lama, yang berarti bahwa sampel diambil dan hasilnya diperoleh lebih cepat dari yang biasa dilakukan

5. Mudah dikerjakan

Skrining tidak memerlukan keahlian atau spesialisasi khusus untuk dilakukan. Apabila tenaga kesehatan telah diberi pelatihan yang cukup singkat, tes dianggap mudah dilakukan.

6. Bebas dari risiko ketidaknyamanan

Jika suatu tes bebas dari risiko dan ketidaknyamanan, itu berarti bahwa prosedurnya tidak memerlukan tindakan invasif dan tidak menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan bagi pasien. Salah satu bentuk ketidaknyamanan adalah timbulnya rasa sakit, atau nyeri, selama prosedur. Test skrining yang lebih baik jika tidak ada tindakan invasif atau rasa sakit.

7. Proyek "sekali dan untuk semua" tidak cukup untuk memantau penyakit dan menemukan penderita.

8. Kebijakan tentang intervensi atau pengobatan yang akan dilakukan setelah skrining dilakukan harus jelas

9. Dapat diterima masyarakat

Dapat diterima di masyarakat mempunyai arti test skrining tidak bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat.

10. Valid

Validitas suatu tes menunjukkan kemampuan, atau ketepatan, suatu tes untuk menghasilkan nilai yang konsisten dengan nilai yang ada di dunia nyata. Dalam dunia kesehatan, ada dua jenis kenyataan: sakit dan tidak sakit. Oleh karena itu, penilaian validitas terdiri dari dua komponen: sensitifitas (kemampuan untuk menilai kondisi

sakit) dan spesifitas (kemampuan untuk menilai kondisi tidak sakit). Dengan kata lain, sensitifitas merupakan kemampuan suatu tes untuk menunjukkan orang yang sakit positif, sedangkan spesifitas adalah kemampuan suatu tes untuk menunjukkan orang yang tidak sakit negative.

11. Reliabel

Jika tes dilakukan lebih dari satu kali terhadap pasien (subjek pengamatan) yang sama pada kondisi yang sama, validitas tes menunjukkan konsistensi (kesamaan) hasil ukur. Sumber ketidaksamaan hasil ukur (bias) dapat berasal dari perbedaan antara pengamat (disebut bias antar pengamat dan pengamat sama) atau perbedaan antara pengamat (disebut bias intra pengamat).

D. Skrining Kesehatan Mental Perinatal

Terdapat beberapa skrining yang dapat digunakan mendeteksi gangguan kesehatan mental perinatal meliputi skrining kecemasan dan depresi yang biasa digunakn sebagai berikut:

1. *Skrining Generalized Anxiety Disorder (GAD) 7*

Skrining GAD 7 digunakan untuk menilai tingkat kecemasan. Tes gangguan kecemasan umum GAD 7 adalah survei singkat yang dirancang untuk menguji apakah seseorang mungkin menderita kecemasan dan memerlukan perawatan lebih lanjut. GAD 7 menunjukkan seberapa sering mereka mendapatkan masalah. Kuesioner GAD 7 merupakan kuesioner yang baru dikembangkan dari GAD 2 di Filandia. Namun dari hasil riset GAD 2 terbukti lebih efektif untuk menilai derajat kecemasan ditinjau dari aspek sifat *psikometrik*. Interpretasi tes PHQ untuk PHQ-9 melihat jawaban untuk kesembilan pertanyaan: Skor jawaban: "Tidak sama sekali" = 0, "Kadang-kadang" = 1, "Sering" = 2,

"Sangat sering" = 3. Hasil tingkat kecemasan : (Sapra et al., 2020)

Hasil riset di Jerman mendapatkan bahwa uji psikometrik menunjukkan bahwa 3 item pertama lebih baik dari pertanyaan 4 item terakhir. (Jordan et al., 2017) Skrining GAD 7 sudah dikembangkan di Indonesia dan sudah dilakukan uji validitas dengan terjemahan bahasa Indonesia. Menurut Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV), gejala kecemasan umumnya.(Novisari & Kemala, 2021) Namun dari hasil studi saat ini untuk diagnostic GAD 7 sudah menggunakan DSM V. (Rusdi Maslim, 2019)

0 – 4 : Kecemasan Minimal

5 – 9 : Kecemasan Ringan

10–14 : Kecemasan Sedang

15-21 : Kecemasan Berat

Tabel 3.1 Kuesioner GAD 7

1 Merasa gelisah, cemas atau amat tegang	0	1	2	3
2 Tidak mampu menghentikan atau mengendalikan rawa khawatir	0	1	2	3
3 Terlalu mengkhawatirkan berbagai hal	0	1	2	3
4 Sulit untuk bersantai	0	1	2	3
5 Sangat gelisah sehingga sulit untuk duduk diam	0	1	2	3
6 Merasa mudah jengkel atau lekas marah	0	1	2	3
7 Merasa takut seolah olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi	0	1	2	3

2. EPDS

Penerapan *Edinburgh Post-partum Depression Scale* (EPDS) digunakan untuk alat skrining risiko depresi pascapersalinan pada primipara dan multipara. Depresi postpartum berdampak mengurangi kebahagiaan, mempengaruhi hubungan ibu dan anak dan membahayakan jiwa ibu dan bayi sampai menyebabkan kematian. Salah satu cara untuk melindungi wanita dari depresi postpartum adalah dengan melakukan skrining menggunakan skrining (EPDS). Dari hasil penelitian EPDS disarankan sebagai alat deteksi depresi nifas pada ibu primipara dan multipara mengingat bahwa depresi nifas kadang terjadi tanpa diketahui dulu sebelumnya. (Soep, 2011) Penggunaan skrining EPDS masih direkomendasikan oleh *American Academy of Pediatrics* untuk digunakan sebagai skrining pada kesehatan mental ibu hamil atau postpartum. (Van Niel & Payne, 2020)

Cox, Holden, dan Sagovsky mendesain EPDS yang dapat digunakan pada 6-8 minggu setelah melahirkan atau pada ibu yang sedang rawat inap atau home visit. EPDS terdiri dari sepuluh pertanyaan dan memerlukan waktu penyelesaian lima menit. Sepuluh pertanyaan dalam EPDS adalah metode yang bermanfaat dan efektif untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami depresi pasca persalinan. Ini mudah digunakan dan telah terbukti efektif. EPDS telah diterjemahkan dan divalidasi di banyak negara, seperti Arab, Cina, Belanda, Perancis, Jerman, Jepang, Norwegia, Vietnam, dan Malaysia. Terjemahan EPDS ke dalam bahasa Indonesia telah selesai dan divalidasi di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat yang ditulis dalam bahasa Indonesia lebih akurat dan dapat

diandalkan bagi wanita Indonesia. (Layliana & Septi Indah Permata Sari, 2021)

Tabel 3.2 Kuesioner EPDS

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban
1	Saya mampu tertawa dan merasakan hal hal yang menyenangkan	a. Sebanyak yang saya bisa b. Tidak terlalu banyak c. Tidak banyak d. Tidak sama sekali
2	Saya melihat segala sesuatu nya kedepan sangat menyenangkan	a. Sebanyak sebelumnya b. Agak sedikit kurang dibandingkan dengan sebelumnya c. Kurang dibandingkan sebelumnya d. Tidak sama sekali
3	Saya menyalahkan diri saya sendiri saat sesuatu terjadi tidak sebagai mana mestinya	a. Ya, setiap saat b. Ya, kadang kadang c. Tidak terlalu sering d. Tidak pernah sama sekali
4	Saya merasa cemas atau merasa khawatir tanpa alasan yang jelas	a. Tidak pernah sama sekali b. Jarang jarang c. Ya, kadang kadang d. Ya, sering sekali
5	Saya merasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas	a. Ya, cukup sering b. Ya, kadang kadang c. Tidak terlalu sering d. Tidak pernah sama sekal
6	Segala sesuatunya terasa sulit untuk dikerjakan	a. Ya, hampir setiap saat saya tidak mampu menanganinya b. Ya, kadang kadang saya tidak mampu menangani seperti biasanya c. Tidak terlalu, sebagian besar berhasil saya tangani d. Tidak pernah, saya mampu mengerjakan segala sesuatu dengan baik

7	Saya merasa tidak bahagia sehingga mengalami kesulitan untuk tidur	a. Ya, setiap saat b. Ya, kadang kadang c. Tidak terlalu sering d. Tidak pernah sama sekal
8	Saya merasa sedih dan merasa diri saya menyedihkan	a. Ya, setiap saat b. Ya, cukup sering c. Tidak terlalu sering d. Tidak pernah sama sekali
9	Saya merasa tidak bahagia sehingga menyebabkan saya menangis	a. Ya, setiap saat b. Ya, cukup sering c. Disaat tertentu saja d. Tidak pernah sama sekali
10	Muncul pikiran untuk menyakiti diri saya sendiri	a. Ya, cukup sering b. Kadang kadang c. Jarang sekali d. Tidak pernah sama sekali

EPDS tidak dapat mendeteksi neurosis, phobia, kecemasan, atau kelainan kepribadian, tetapi dapat digunakan untuk mengidentifikasi depresi postpartum. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa EPDS sangat sensitif dan spesifik. Perasaan sang ibu dalam satu minggu terakhir ditampilkan dalam skala penilaian EPDS. Panduan pelaksanaan skrining depresi pascapersalinan dengan tools EPDS adalah:

- Ibu pascapersalinan diharapkan dapat memberikan jawaban pertanyaan skrining setidaknya dalam kurun waktu 7 hari terakhir terkait perasan kondisi saat ini
- Pertanyaan dari form skrining harus dijawab semua tanpa terkecuali
- Jawaban dari kuesioner skrining harus benar-benar dari ibupascapersalinan, tanpa mendiskusikan jawaban dengan orang lain. Kecuali ibu mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan yang diajukan.

Penilaian dalam setiap jawaban pertanyaan pada kuesioner EPDS adalah sebagai berikut:

- a. Tiap pertanyaan mempunyai 4 pilihan alternatif, masing-masing diberi nilai dari 0 hingga 3 untuk setiap pilihan.
- b. Untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 4 diberikan nilai 0 untuk jawaban "a", nilai 1 untuk jawaban "b", nilai 2 untuk jawaban "c", dan nilai 3 untuk jawaban "d"
- c. Pada pertanyaan no 3,5 sampai dengan 10 merupakan penilain terbalik dengan hasil penilaian diberikan nilai 3 apabila menjawab "a", nilai 2 apabila menjawab "b", nilai 1 jika menjawab "c", dan nilai 0 jika menjawab "d"
- d. Pertanyaan no 10 merupakan pertanyaan yang menunjukkan keinginan bunuh diri.
- e. Nilai maksimal: 30
- f. Kemungkinan depresi apabila nilai lebih dari 10

Interpretasi hasil penilaian skrining EPDS adalah

- a. Skor EPDS 9-10 maka direkomendasikan untuk menjalani skrining selanjutnya.
- b. Pada wanita yang mendapatkan total skor EPDS lebih dari 10, berisiko tinggi untuk terjadinya depresi postpartum
- c. Para ibu yang memiliki skor diatas 10 biasanya menderita suatu depresi dengan tingkat keparahan yang bervariasi.
- d. Dalam hal pertanyaan nomor 10, jawaban "ya" sangat sering menunjukkan bahwa seseorang harus segera menerima perawatan psikiatri. Penanganan psikiatri sangat penting bagi wanita dengan gangguan fungsi, yang ditunjukkan dengan penghalang dari keluarga dan teman, ketidakmampuan menjaga kebersihan diri, atau ketidakmampuan merawat bayi mereka sendiri.

- e. Wanita yang memiliki skor antara 5 dan 9 tanpa adanya pikiran untuk bunuh diri sebaiknya dilakukan evaluasi ulang setelah 2 minggu untuk menentukan apakah episode depresi mengalami perburukan atau membaik.

Terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan skrining dengan EPDS adalah sebagai berikut:

- a. Mudah dihitung oleh tenaga kesehatan
- b. Cepat dikerjakan (lima s/d 10 menit)
- c. Deteksi dini dilakukan terhadap depresi pascapersalinan
- d. Lebih diterima oleh ibu pascapersalinan
- e. Ekonomis

Kekurangan penggunaan skrining EPDS yaitu:

- a. Tidak dapat mendiagnosis depresi pascapersalinan
- b. Tidak dapat mengidentifikasi faktor risiko penyebab adanya depresi pascapersalinan.

3. Skrining Patient Health Questionnaire (PHQ) 9

Skrining PHQ 9 merupakan skrining untuk melihat tingkat awal keparahan depresi yang dialami oleh seseorang. Indikator pertanyaan terdiri dari 9 item pertanyaan. PHQ terbukti efektif untuk menilai depresi secara umum. PHQ tidak hanya digunakan untuk mengukur depresi pada ibu pasca persalinan namun pada depresi pada pasien lainnya. Skrining ini pernah digunakan untuk penelitian di Amerika. (Hantsoo et al., 2018) Interpretasi tes PHQ untuk PHQ-9 melihat jawaban untuk kesembilan pertanyaan: Skor jawaban: "Tidak sama sekali" = 0, "Kadang-kadang" = 1, "Sering" = 2, "Sangat sering" = 3. Total 9 pertanyaan

menggunakan penilaian ini untuk menunjukkan tingkat depresi klien. Kriteria penilaian sebagai berikut:

- 0 – 4 : Tidak ada untuk Depresi Minimal
- 5 – 9 : Depresi ringan
- 10 – 14 : Depresi Sedang
- 15 – 19 : Depresi Cukup Berat
- 20 – 27 : Depresi Berat

Hasil riset di Latvia PHQ 9 terbukti efektif untuk mengukur derajat depresi. Di Indonesia skrining PHQ 9 pernah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil menunjukan bahwa PHQ 9 terbukti efektif di gunakan di Indonesia(Vrublevska et al., 2018). Adapun item pertanyaan PHQ 9 : (Dian et al., 2022)

Tabel 3.3 Kuesioner PHQ 9

1 Kurang tertarik atau kurang suka dalam melakukan apapun	0	1	2	3
2 Merasa murung, pilu, atau putus asa	0	1	2	3
3 Sulit untuk tidur atau bertahan tidur, atau terlalu banyak tidur	0	1	2	3
4 Merasa lelah atau tidak bertenaga	0	1	2	3
5 Kurang nafsu makan atau terlalu banyak makan	0	1	2	3
6 Kurang percaya diri atau merasa bahwa anda adalah orang yang gagal atau telah mengecewakan diri sendiri atau keluarga	0	1	2	3
7 Sulit berkonsentrasi pada sesuatu misalnya membaca koran atau menonton televise	0	1	2	3

8	Bergerak atau berbicara sangat lambat sehingga orang lain memperhatikannya. Atau sebaliknya merasa resah atau gelisah sehingga anda lebih sering bergerak dari biasanya	0	1	2	3
9	Merasa lebih baik mati atau ingin melukai diri sendiri dengan cara apapun	0	1	2	3

4. Self Reporting Questionnaire (SRQ) 20

Salah satu metode yang relatif murah, mudah, dan efektif untuk mengidentifikasi adanya gangguan mental emosional adalah skrining SRQ. Dikatakan murah karena dapat dilakukan dengan cepat dan tidak memerlukan penilaian khusus. SRQ adalah skrining yang rekomendasikan oleh WHO untuk gangguan psikiatrik yang terdiri dari 20 pertanyaan. SRQ terdiri dari dua alternative jawaban yaitu "Ya" dan "Tidak". Mungkin pasien mengalami gangguan psikiatrik jika minimal enam jawaban "Ya" diberikan. SRQ dapat digunakan untuk meniai gejala gangguan mental seperti depresi, ansietas, kognitif, somatik, dan penurunan energi. Pertanyaan SRQ yang diajukan pasien adalah masalah yang dia alami selama tiga puluh hari terakhir.

Tabel 3.4 Kuesioner SRQ

No	Pertanyaan	Y	T
1	Apakah anda sedang sering menderita sakit kepala?		
2	Apakah anda tidak nafsu makan?		
3	Apakah anda sulit tidur?		
4	Apakah anda mudah takut?		
5	Apakah anda merasa tegang, cemas atau		

	khawatir?
6	Apakah tangan anda gemetar?
7	Apakah pencernaan anda terganggu/ buruk?
8	Apakah anda sulit untuk berpikir jernih?
9	Apakah anda merasa tidak bahagia?
10	Apakah anda menangis lebih sering?
11	Apakah anda merasa sulit untuk menikmati kegiatan sehari-hari?
12	Apakah anda sulit untuk mengambil keputusan?
13	Apakah perjalanan sehari-hari anda terganggu?
14	Apakah anda tidak mampu melakukan hal- hal yang bermanfaat dalam hidup?
15	Apakah anda kehilangan minat pada berbagai hal?
16	Apakah anda merasa tidak berharga?
17	Apakah anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup?
18	Apakah anda merasa lelah sepanjang waktu?
19	Apakah anda mengalami rasa tidak enak di perut?
20	Apakah anda mudah lelah?

Penentuan penilaian pada skrining SRQ 20 berdasarkan jumlah jawaban < 6 menjawab "Ya" maka di lakukan promosi kesehatan tentang pola hidup sehat. Dan jika terdapat jawaban "Ya" > 6 maka dilakukan promosi kesehatan dan di rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk di lakukan prevensi gangguan jiwa dan pemeriksaan lanjutan. Prevensi gangguan jiwa dilakukan dengan mengatasi faktor resiko, tanda dan gejala yang dialami. Pemeriksaan lanjutan yang dilakukan adalah wawancara

psikiatrik, lalu dilakukan tatalaksana multidisiplin sesuai diagnosis psikiatrik. (Kemenkes RI, 2021)

Dari beberapa skrining tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya skrining EPDS yang mendeteksi tentang PMH pada ibu pasca persalinan. Namun hanya mendeteksi satu cakupan PMH yaitu depresi pasca persalinan. Skrining EPDS tidak bisa mendeteksi untuk mengetahui faktor resiko penyebab PMH.(Layliana & Septi Indah Permata Sari, 2021) Skrining EPDS sudah direkomendasikan oleh WHO untuk mendeteksi PMH berupa depresi pada ibu pasca persalinan.(WHO, 2022) Idealnya skrining PMH mampu mencakup dua cakupan PMH.(Price et al., 2021) Jika ditinjau dari perubahan adatasi psikologis pada ibu pasca persalinan, sebelum mengalami depresi ibu pasca persalinan mengalami kecemasan terlebih dahulu.(Layliana & Septi Indah Permata Sari, 2021) Dan jika tidak tertangani dengan baik maka ibu dapat mengalami depresi dengan tambahan gejala depresi lainnya selain kecemasan, seperti konsentrasi yang kurang, rasa percaya diri berkurang, merasa tidak berguna, nafsu makan menurun, gangguan tidur dan muncul perasaan untuk menyakiti diri sendiri atau bayinya.(Rusdi Maslim, 2019)

5. Skrining *Depression Anxiety* (DAS) 21
Skrining DASS 21 atau singkatan dari *Depression Anxiety Stress Scales* 21 merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur depresi, kecemasan dan stress. Instrumen ini sudah digunakan di beberapa Negara yakni diantaranya yaitu Australia, Indonesia dan Vietnam.(Price et al., 2021)(Minh Thi Hong Le^{1*}, Thach Duc Tran¹, Sara Holton¹, Huong Thanh Nguyen², Rory Wolfe³, 2020) Jenis instrumen ini tidak hanya digunakan pada ibu pasca persalinan namun

dapat juga digunakan bagi pasien umum lainnya. Skrining DAS 21 terdiri dari 21 item pertanyaan. Tiga skala DASS-21 terdiri dari tujuh item, yang dibagi menjadi subskala dengan item yang sebanding. Dysphoria, keputusan, evaluasi kehidupan, mencela diri sendiri, kurangnya minat atau keterlibatan, anhedonia, dan inersia adalah semua gejala yang dinilai dalam skala depresi. Skala kecemasan sensitif terhadap tingkat gairah kronis non-spesifik, gairah otonom, efek otot rangka, dan kecemasan situasional. Ini menilai kesulitan bersantai, gairah gugup, mudah marah atau gelisah, mudah tersinggung/terlalu reaktif, dan tidak sabar. Untuk menentukan depresi, kecemasan, dan stres, skor untuk masing-masing item dijumlahkan.(Price et al., 2021)

Tabel 3.5 Scoring DAS 21

	Depression	Anxiety	Stress
Normal	0-9	0-7	0-14
Ringan	10-13	8-9	15-18
Sedang	14-20	10-14	19-25
Berat	21-27	15-19	26-33
Sangat Berat	28+	20+	34+

Petunjuk :

0 : Tidak pernah

1 : Kadang-kadang

2 : Sering

3 : Sangat sering

DASS 21 bukanlah untuk menggantikan wawancara klinis untuk penegakan diagnosa. Skrining ini hanya digunakan untuk deteksi dini status kesehatan mental seseorang. Hasil penelitian di vietnam menyatakan bahwa secara umum dari ketiga cakupan item penilaian DAS 21 depresi dan

kecemasan terbukti efektif untuk melakukan skrining kesehatan mental, namun pada item stress DASS 21 dinyatakan masih kurang efektif.(Minh Thi Hong Le^{1*}, Thach Duc Tran¹, Sara Holton¹, Huong Thanh Nguyen², Rory Wolfe³, 2020) Stress tidak termasuk dalam cakupan PMH. Stress pada ibu pasca persalinan merupakan respon perubahan terhadap adaptasi psikologi yang tidak mampu dijalankan oleh ibu pasca persalinan. Respon stress yang diberikan dapat berupa cakupan PMH. (WHO, 2022) DASS 21 merupakan kuesioner yang digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan yang dialami oleh seseorang dari 3 item cakupan DASS 21 yaitu stress, kecemasan dan depresi.(Kelompok Studi Imunodermatologi Indonsia, 2016)

BAB 4

Efektifitas Pelatihan Skrining Kesehatan Mental Perinatal terhadap Pengetahuan, Sikap dan Praktik Bidan

A. Efektivitas Pelatihan terhadap Pengetahuan Bidan tentang Skrining Kesehatan Mental Perinatal

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas bidan dalam melakukan skrining kesehatan mental perinatal pada ibu pascapersalinan, disusun sebuah program pelatihan sebagai bagian dari intervensi dalam pengembangan model skrining. Pelatihan ini dirancang secara sistematis dan berbasis kebutuhan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan bidan terkait konsep, cakupan, serta langkah-langkah skrining PMH yang sesuai dengan konteks pelayanan di puskesmas. Materi pelatihan mencakup pengenalan gangguan mental pada masa pascapersalinan, penggunaan instrumen skrining yang sesuai, serta pendekatan komunikasi dan empati dalam proses skrining. Pelatihan diberikan kepada kelompok intervensi yang telah ditentukan, sementara kelompok kontrol

tidak menerima pelatihan, sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk melihat efektivitas intervensi tersebut.

Setelah pelatihan diberikan, dilakukan pengukuran tingkat pengetahuan bidan melalui pre test dan post test untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan pada kelompok yang mengikuti pelatihan. Rerata skor pengetahuan bidan meningkat setelah pelatihan, mencerminkan bahwa informasi yang disampaikan mampu dipahami dan diserap dengan baik oleh peserta. Sebaliknya, pada kelompok kontrol yang tidak mendapatkan pelatihan, tidak terjadi peningkatan berarti, bahkan terdapat sedikit penurunan skor. Hal ini menjadi indikator bahwa tanpa intervensi berupa pelatihan, pemahaman tentang skrining PMH cenderung stagnan dan tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan terbukti menjadi strategi penting dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.

Temuan ini memperkuat pentingnya program pelatihan sebagai komponen utama dalam pengembangan model skrining PMH ibu pascapersalinan. Tidak hanya berperan dalam peningkatan pengetahuan, pelatihan juga dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran dan motivasi bidan dalam mengintegrasikan aspek kesehatan mental ke dalam pelayanan rutin pascapersalinan. Dalam jangka panjang, peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan skrining yang lebih sistematis, efektif, dan berkelanjutan, serta berdampak pada penurunan risiko gangguan kesehatan mental pada ibu, sehingga kualitas hidup ibu dan anak dapat terjaga secara menyeluruh.

Peningkatan pengetahuan bidan melalui pelatihan tentang skrining kesehatan mental perinatal pada ibu pascapersalinan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas layanan kesehatan ibu dan bayinya. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada bidan, meliputi konsep kesehatan mental, psikologi ibu pascapersalinan, pelaksanaan skrining, hingga peran bidan dalam mendeteksi dan menangani masalah PMH. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intervensi berupa pelatihan terbukti secara signifikan meningkatkan pengetahuan bidan, sehingga mereka lebih siap dalam melakukan skrining secara teknis dan empatik. Buku ini menekankan pentingnya pelatihan yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara berkelanjutan agar kompetensi bidan tetap terjaga dan berkembang seiring dengan dinamika ilmu pengetahuan dan kebijakan kesehatan. Dengan pelatihan yang tepat, bidan sebagai garda terdepan layanan kesehatan dapat memberikan deteksi dini PMH secara optimal, sehingga dampak jangka panjang pada ibu dan anak dapat dicegah sejak awal (Vijayalakshmi Poreddi Sailaxmi Gandhi Ramachandra et al., 2023) (Lois et al., 2024) (Marine Dubreucq et al., 2023).

Berdasarkan teori Stimulus-Organisme-Response (SOR), perubahan perilaku bidan dalam melakukan skrining Perinatal Mental Health (PMH) dapat terjadi melalui stimulus yang diberikan dalam bentuk pelatihan. Stimulus ini berperan sebagai proses pembelajaran yang merangsang peningkatan pengetahuan, di mana informasi yang diperoleh selama pelatihan akan diproses oleh individu dan menghasilkan respons berupa pemahaman, sikap positif, serta keterampilan baru. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan kesehatan, pengalaman, dan lingkungan sosial yang

mendukung selama pelatihan berlangsung. Dengan pelatihan yang terarah, bidan diberdayakan untuk memahami pentingnya deteksi dini PMH, mengenali tanda-tandanya, serta menggunakan instrumen skrining secara tepat dan mandiri. Upaya ini menjadi bentuk pemberdayaan tenaga kesehatan agar mampu mengambil peran aktif dalam mendeteksi dan mencegah gangguan kesehatan mental pada ibu pascapersalinan, serta memberikan layanan yang lebih responsif dan berkualitas kepada ibu dan bayi (Soekidjo Notoatmodjo, 2014) (Soekidjo Notoatmodjo, 2020).

Hasil evaluasi pengetahuan pada kelompok kontrol memberikan gambaran nyata mengenai dampak tidak adanya intervensi dalam bentuk pelatihan. Bidan yang tidak mendapatkan pelatihan skrining kesehatan perinatal menunjukkan kecenderungan stagnasi bahkan penurunan pengetahuan setelah periode waktu tertentu. Tidak ditemukan perbedaan signifikan antara hasil pre-test dan post-test, bahkan rata-rata skor pengetahuan justru mengalami penurunan. Penurunan ini terlihat pada tujuh aspek penting dalam pertanyaan pengetahuan, seperti pemahaman tentang faktor risiko PMH, tanda dan gejala, tujuan dan pelaksanaan skrining, serta bentuk gangguan seperti baby blues, depresi, dan psikosis. Temuan ini konsisten dengan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa tanpa pelatihan tambahan, bidan berisiko tidak mengetahui atau memahami aspek penting dari skrining PMH pada ibu pasca persalinan. Kurangnya peningkatan pengetahuan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lingkungan kerja yang tidak mendukung, rendahnya rasa percaya diri, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya atau literatur pendidikan tambahan. Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa pelatihan

berkelanjutan merupakan bagian integral dalam pemberdayaan bidan, agar mereka dapat menjalankan skrining PMH secara efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu pasca persalinan (Marine Dubreucq et al., 2023) (Maralyn Foureur, 2019).

Pemberian pelatihan secara berkesinambungan serta intervensi pendidikan kesehatan kepada bidan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi mereka, khususnya dalam melaksanakan skrining kesehatan mental perinatal pada ibu pasca persalinan. Ketidaksediaan program pelatihan khusus mengenai skrining kesehatan mental perinatal menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan bidan kurang terampil dalam mengidentifikasi masalah kesehatan mental pada ibu pasca persalinan secara menyeluruh. Tanpa pelatihan yang memadai, bidan berisiko tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mendeteksi secara dini kondisi mental ibu, sehingga dapat berdampak pada keterlambatan penanganan dan menurunnya kualitas pelayanan kebidanan.

Oleh karena itu, dibutuhkan program pelatihan yang terstruktur, komprehensif, dan berkelanjutan agar bidan memiliki pengetahuan terkini serta kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kesehatan mental dalam masa perinatal. Pelatihan ini juga harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mendorong bidan untuk senantiasa memperbaharui keterampilan mereka seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan dalam bidang kesehatan mental ibu. Bidan yang tidak pernah mendapatkan pelatihan memiliki potensi besar untuk menghadapi kendala dalam menjalankan peran dan fungsinya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi mutu pelayanan kebidanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pelatihan bukan hanya sekadar transfer ilmu, tetapi merupakan investasi penting untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh (Vijayalakshmi Poreddi Sailaxmi Gandhi Ramachandra et al., 2023) (Marine Dubreucq et al., 2023).

B. Sikap Bidan Terhadap Kesehatan Mental Perinatal

Pengukuran terhadap sikap bidan dilakukan pada dua titik waktu, yaitu sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) pemberian intervensi. Hasil analisis pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa terjadi penurunan rerata skor sikap sebesar -0,16 setelah intervensi diberikan. Namun demikian, uji statistik Wilcoxon menunjukkan bahwa perubahan ini tidak signifikan secara statistik, dengan nilai p sebesar 0,419 ($p > 0,05$). Artinya, tidak terdapat perbedaan sikap yang bermakna antara sebelum dan sesudah intervensi dalam kelompok intervensi. Temuan ini juga konsisten dengan hasil yang diperoleh pada kelompok kontrol. Pada kelompok ini, rerata skor sikap juga mengalami penurunan, bahkan lebih besar dibandingkan kelompok intervensi, yaitu sebesar -0,47. Meskipun demikian, penurunan ini juga tidak signifikan secara statistik, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai p yang tetap berada di atas ambang signifikansi 0,05.

Selanjutnya, hasil uji Mann-Whitney dilakukan untuk mengetahui perbedaan sikap antar kelompok (intervensi dan kontrol) baik pada saat pre-test maupun post-test. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok pada kedua waktu pengukuran tersebut. Nilai p untuk perbandingan pada saat pre-test adalah 0,193, sedangkan pada saat post-test adalah 0,137 ($p > 0,05$ untuk keduanya). Secara keseluruhan, temuan

ini menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan belum mampu menghasilkan perubahan signifikan dalam sikap bidan terhadap skrining kesehatan mental perinatal, baik dibandingkan sebelum intervensi maupun jika dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Sikap bidan yang sudah diberikan intervensi berupa pemberian pelatihan tentang skrining PMH tidak mengalami perubahan secara signifikan. Namun sikap bidan pada kelompok intervensi lebih baik dibandingkan kelompok kontrol. Terjadi penurunan rata-rata sikap bidan dari pre test ke post test pada kelompok intervensi sebesar 0,22. Sedangkan pada kelompok kontrol penurunan sebesar 0,47. Secara statistik *p value* pada kelompok intervensi dan control sama-sama $> 0,05$. Pada kelompok intervensi sebesar 0,419 dan kelompok kontrol sebesar 0,480. Kurangnya dukungan dari berbagai sistem layanan kesehatan dan organisasi tempat bidan bekerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap bidan cenderung tidak mengalami perubahan. Dari hasil studi lainnya didapatkan bahwa meskipun bidan sudah cukup memiliki pengetahuan yang memadai setelah diberikan pelatihan, namun seringkali bidan mempunyai hambatan dalam melaksanakan praktek kebidanan sehari-hari, diantaranya yaitu adanya keterbatasan waktu, sumber daya, dan dukungan dari pihak manajemen. Tidak adanya dukungan yang memadai, dapat membuat bidan merasa terbebani dalam melaksanakan sesuatu yang didapatkan dari hasil penambahan pengetahuan baru yang bidan miliki saat melaksanakan skrining PMH ibu pasca persalinan. (Baker et al., 2020)(WHO, 2024b)

Beberapa faktor lainnya yang dapat membuat bidan tidak mengalami perubahan sikap yaitu adanya beban kerja yang tinggi. Hasil studi menunjukkan bahwa seorang bidan yang mempunyai tanggung jawab yang beragam cenderung memiliki keterbatasan waktu untuk melayani pasien. Bidan hanya akan lebih fokus kepada tugas yang lebih prioritas dengan mengesampingkan kegiatan untuk skrining PMH ibu pasca persalinan. Kemungkinan bidan akan merasa tidak nyaman dalam melakukan skrining karena menganggap bahwa kegiatan skrining akan menghambat bidan dalam menjalankan pekerjaan lainnya. Ditemukan bahwa banyak bidan yang merasa kurang percaya diri dalam melakukan praktek kebidanan meskipun sudah mempunyai keterampilan yang cukup. Hal ini kemungkinan disebabkan juga karena adanya perubahan terbentuknya sikap yang relatif singkat hanya melalui pelatihan. Bidan mempunyai pandangan bahwa kegiatan skrining PMH ibu pasca persalinan bukan merupakan tanggung jawab utama. Terbentuknya keyakinan yang mendalam membutuhkan intervensi yang lebih lama. (Baker et al., 2020)(Rohani Rohani & Cesa Septiana Pratiwi, 2024)(McCauley et al., 2011)

Pada kelompok kontrol tidak terjadi perubahan sikap secara signifikan yang tidak mendapatkan intervensi berupa pelatihan. Sebagian besar terjadi penurunan pada beberapa sikap positive hasil pre menuju hasil post test. Beberapa hasil studi menemukan bahwa kurangnya informasi yang didapatkan bidan dan kesadaran dapat menyebabkan bidan menilai bahwa skrining PMH ibu pasca persalinan merupakan bagian yang kurang penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap layanan kesehatan kebidanan. Bidan kemungkinan akan lebih cenderung untuk melaksanakan keterampilan dan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya dalam

menangani masalah kesehatan pada ibu pasca persalinan. Tidak adanya intervensi pelatihan dapat membuat bidan merasa tidak perlu untuk melaksanakan skrining secara rutin kepada ibu pasca persalinan. Kebiasaan rutin akan sulit untuk dapat dirubah tanpa adanya dukungan atau dorongan dari external. (Lois et al., 2024)(Noonan et al., 2018)

Salah satu faktor yang dapat mendorong bidan untuk melakukan skrining PMH pada ibu pasca persalinan adalah dukungan dari sistem layanan kesehatan yang berada di tempat bekerja. Pemberian pelatihan kepada bidan merupakan suatu bentuk dukungan yang dapat menguatkan bidan untuk dapat mempunyai sikap yang positif terhadap skrining PMH ibu pasca persalinan. Dukungan lainnya yang dibutuhkan bidan untuk dapat menganggap bahwa skrining PMH itu penting diantaranya yaitu kebijakan di wilayah setempat dan sistem manajemen kesehatan. (Rohani Rohani & Cesa Septiana Pratiwi, 2024)(Agnes Higgins et al., 2018) Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa beberapa faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan skrining PMH yaitu faktor demografi, pendapatan, tingkat pendidikan, asuransi kesehatan, calon peserta yang akan di skrining, tenaga kesehatan atau sistem layanan kesehatan dan kebijakan program. Pengetahuan dan sikap adalah komponen tenaga kesehatan. Ada hubungan antara praktik skrining dan sistem layanan kesehatan. (Gimeno Garca, 2012)(Nithianandan et al., 2016)

C. Praktik Bidan dalam melakukan skrining Kesehatan Mental Perinatal

Pengukuran praktik bidan dalam melaksanakan skrining kesehatan mental perinatal dilakukan pada dua waktu, yaitu sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) intervensi. Pada kelompok intervensi, hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan rerata skor praktik yang cukup signifikan. Sebelum intervensi, rerata skor praktik tercatat sebesar 9,20 (SD 2,26), dan meningkat menjadi 12,30 (SD 1,87) setelah intervensi. Peningkatan ini sebesar 3,1 poin. Berdasarkan uji Wilcoxon, peningkatan ini signifikan secara statistik dengan nilai p sebesar 0,001 ($p < 0,05$). Artinya, terdapat perbedaan yang bermakna antara praktik bidan sebelum dan sesudah pemberian intervensi.

Fenomena serupa juga ditemukan pada kelompok kontrol. Meskipun tidak menerima intervensi secara langsung, kelompok ini mengalami peningkatan rerata skor praktik dari 9,10 (SD 2,09) menjadi 10,67 (SD 3,02), dengan selisih sebesar 1,57 poin. Hasil uji Wilcoxon juga menunjukkan peningkatan ini signifikan secara statistik, dengan nilai p sebesar 0,002 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan praktik skrining yang bermakna pada kedua kelompok, baik intervensi maupun kontrol. Selanjutnya, untuk menilai perbedaan antar kelompok, dilakukan uji Mann-Whitney terhadap nilai pre-test dan post-test. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara praktik skrining bidan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol, baik pada saat pre-test ($p = 0,862$) maupun post-test ($p = 0,068$).

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari nilai delta (selisih antara post-test dan pre-test), terlihat bahwa peningkatan skor praktik pada kelompok intervensi ($\Delta = 3,1$) lebih besar dibandingkan kelompok kontrol ($\Delta = 1,57$). Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa intervensi yang diberikan memiliki potensi untuk meningkatkan praktik skrining bidan, meskipun perbedaan tersebut belum mencapai signifikansi secara statistik antar kelompok. Temuan dari hasil studi lainnya menunjukkan bahwa adanya pemberian pelatihan tersebut akan menstimulasi bidan untuk dapat membantu mengembangkan keterampilan secara praktis untuk dapat melaksanakan skrining secara efektif. Informasi yang diperoleh saat pelatihan dapat meningkatkan nilai praktik bidan dalam melakukan skrining.(Wang et al., 2021)(Vijayalakshmi Poreddi Sailaxmi Gandhi Ramachandra et al., 2023) Bidan akan belajar untuk menggunakan alat skrining yang digunakan dan praktik langsung untuk melakukan skrining. Menurut teori *drive reduction* menyatakan bahwa seluruh kegiatan perilaku manusia merupakan sesuatu yang dilakukan berdasarkan atas proses belajar yang sudah dialami terlebih dahulu. Belajar bisa diperoleh melalui pengalaman sebelumnya yang didapatkan melalui adanya penambahan informasi-informasi sebelumnya. (Herri Zan Pieter & Namora Lumongga Lubis, 2014)

Beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku bidan dalam melakukan skrining dari hasil studi lainnya yaitu adanya pengembangan kepercayaan diri yang terbentuk setelah diberikan pelatihan. Bidan yang sudah mendapatkan intervensi akan mempunyai keyakinan diri untuk melakukan skrining PMH pada ibu pasca persalinan. (Leila Nisya Ayuanda et al., 2022)(Lois et al., 2024) Menurut teori *Bloom* perilaku kesehatan terdiri dari 3 (tiga) domain yaitu pengetahuan, sikap dan

keterampilan. Seseorang yang akan mengadopsi perilaku yang baru maka harus mengetahui terlebih dahulu tentang manfaat yang akan didapatkan. Dalam hal ini bidan yang sudah diberikan pelatihan tentang skrining PMH akan mengetahui manfaat yang akan didapatkan, sehingga terjadi perubahan perilaku yang baru dari hasil adopsi yang diperoleh melalui pelatihan. Adanya pelatihan akan memberikan dampak positif terhadap keterampilan bidan. (Wang et al., 2021)(Soekidjo Notoatmodjo, 2014)

Bidan yang berada pada kelompok kontrol yang tidak mendapatkan pemberian pelatihan terjadi peningkatan nilai praktik meskipun tidak signifikan. Hal ini karena masih terdapat nilai praktik bidan yang mengalami penurunan pada tindakan yang tepat dari hasil post test. Terjadinya peningkatan nilai praktik pada kelompok kontrol dari hasil studi lainnya kemungkinan didapatkan melalui pembelajaran mandiri. Pada kelompok kontrol bidan mendapatkan buku panduan terkait pelaksanaan skrining PMH pada ibu pasca persalinan. Kebidanan merupakan pelayanan yang terampil, bepengetahuan dan penuh kasih sayang untuk wanita hamil ataupun pasca melahirkan. Maka bidan akan secara aktif dapat mencari informasi mencakup membaca literatur, mengikuti seminar atau webinar, dan menggunakan sumber daya offline atau online.(WHO, 2024a)(Layliana & Septi Indah Permata Sari, 2021)(Maisyarah et al., 2021) Dalam hal ini bidan dapat memperoleh informasi pelaksanaan skrining yang diperoleh dari teman sejawat yang sudah mengikuti pelatihan skrining PMH ibu pasca persalinan.

Adanya pengaruh positif dari teman sejawat dapat meningkatkan keterampilan yang lebih baik dan dapat membantu bidan dalam meningkatkan kemampuan untuk melakukan skrining. Bidan dapat melakukan diskusi secara informal dari berbagai pengalaman antara sesama bidan. Hal ini dapat menjadi suatu pembelajaran yang efektif. Bidan yang mendapatkan dukungan dan pengaruh dari teman sejawat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keterampilan bidan.(Margaret Carroll et al., 2018)(Marie Hastings-Tolsma Annie Temane et al., 2021) Selain itu dengan kondisi saat ini dengan kemajuan teknologi yang sudah semakin pesat, bidan dapat memperoleh informasi melalui media online melalui YouTube tentang berbagai aspek layanan kesehatan termasuk skrining PMH ibu pasca persalinan.(Maisyarah et al., 2021)

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa karena masing-masing kelompok adalah kelompok independen yang berbeda, tidak ada perbedaan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Dalam melakukan skrining PMH pada Ibu Pascapersalinan kelompok intervensi menggunakan model skrining yang baru. Kelompok kontrol menggunakan dalam mendeteksi PMH pada ibu pascapersalinan menggunakan model skrining yang lama. Menurut teori terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan hasil uji *Man Whitney* tidak signifikan yaitu perubahan distribusi yang tidak merata dan tidak terlalu besar, serta jumlah sampel yang tidak memadai untuk mendeteksi adanya perbedaan. Meskipun hasil uji *Wilcoxon* yang lebih sensitif terhadap perubahan dalam kelompok yang sama. (Riduwan, 2013) Keterampilan merupakan suatu bentuk implementasi dari pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.(Soekidjo Notoatmodjo, 2014) Praktik bidan dalam

melakukan skrining PMH pada ibu pascapersalinan merupakan bentuk pengetahuan yang dimiliki. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan yaitu secara formal atau non formal. Gabungan dari pendidikan, pelatihan, pengalaman, observasi, dan interaksi sosial. (Soekidjo Notoamtmodjo, 2020) Bidan pada kelompok intervensi dapat memperoleh pengetahuan melalui pelatihan yang diberikan. Bidan pada kelompok kontrol dapat memperoleh pengetahuan pada pengalaman selama menjasi bidan.

D. Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Praktik Bidan dengan Pelatihan Skrining Kesehatan Mental Perinatal

Pelatihan merupakan salah satu intervensi penting dalam upaya meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, termasuk dalam konteks skrining kesehatan mental perinatal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, pelatihan terbukti memiliki hubungan yang bermakna terhadap peningkatan pengetahuan bidan. Hasil uji korelasi biserial menunjukkan bahwa pelatihan berhubungan secara signifikan dengan pengetahuan, dengan koefisien korelasi sebesar 0,489 dan nilai p sebesar 0,001. Nilai ini mengindikasikan adanya hubungan sedang yang signifikan secara statistik, yang berarti bahwa pelatihan memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman bidan terhadap topik skrining kesehatan mental.

Selain pengetahuan, pelatihan juga menunjukkan adanya pengaruh terhadap sikap bidan. Namun, kekuatan hubungan ini lebih rendah dibandingkan dengan hubungan terhadap pengetahuan. Koefisien korelasi biserial yang tercatat adalah sebesar 0,257 dengan nilai p sebesar 0,005. Meski tergolong dalam kategori hubungan yang lemah, nilai p yang signifikan menunjukkan bahwa pelatihan tetap berkontribusi terhadap

pembentukan sikap bidan, walaupun tidak sekuat kontribusinya terhadap pengetahuan.

Berbeda halnya dengan praktik. Hubungan antara pelatihan dan praktik bidan dalam melakukan skrining terlihat sangat lemah. Nilai korelasi biserial tercatat hanya sebesar 0,163, dengan nilai p sebesar 0,075. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik, hubungan antara pelatihan dan praktik tidak signifikan. Artinya, peningkatan praktik bidan dalam skrining tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh pelatihan yang diberikan. Hal ini membuka ruang diskusi bahwa perubahan praktik mungkin memerlukan lebih dari sekadar peningkatan pengetahuan atau pembentukan sikap—misalnya dukungan sistem, pengalaman langsung, atau insentif yang memadai.

Temuan-temuan ini memberikan pemahaman penting bahwa pelatihan memang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sedikit berpengaruh terhadap sikap, namun belum cukup untuk mendorong perubahan praktik secara signifikan. Oleh karena itu, strategi pelatihan mungkin perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain yang lebih komprehensif dan kontekstual untuk mendorong perubahan perilaku dalam praktik sehari-hari.

Salah satu faktor yang mendasari perbedaan hasil ini adalah ukuran sampel dan durasi evaluasi yang digunakan. Penelitian di India melibatkan 60 responden per kelompok, dengan periode evaluasi berlangsung selama 3 hingga 6 bulan. Di sisi lain, penelitian di Australia menggunakan 40 responden dalam kelompok pra dan pasca-tes, dengan penyediaan pendidikan kesehatan daring. Perbedaan dalam ukuran sampel dan metode pelaksanaan kemungkinan akan memengaruhi efektivitas pelatihan terhadap perubahan sikap dan praktik bidan dalam

skrining kesehatan mental perinatal. (Vijayalakshmi Poreddi Sailaxmi Gandhi Ramachandra et al., 2023),(Lois et al., 2024) Penyediaan intervensi pelatihan berkelanjutan sangat penting bagi bidan untuk memastikan mereka dapat terus memperbarui pengetahuan mereka sejalan dengan perkembangan terbaru di bidang kesehatan mental, khususnya bagi ibu pascapersalinan.(Marine Dubreucq et al., 2023) Temuan lain menunjukkan bahwa meskipun bidan sudah memiliki pengetahuan yang memadai setelah pelatihan, namun tidak terjadi perubahan dalam sikap dan praktik. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan waktu bidan dalam melayani pasien, hanya berfokus pada tugas prioritas, dan kurangnya rasa percaya diri. (Baker et al., 2020),(Rohani Rohani & Cesa Septiana Pratiwi, 2024) Kurangnya rasa percaya diri dapat terjadi karena relatif singkatnya waktu pembentukan sikap dan praktik bidan melalui pelatihan. (McCauley et al., 2011)

E. Strategi Pelatihan Untuk Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Praktik Bidan

Agar pelatihan bagi bidan dalam skrining kesehatan mental perinatal dapat menghasilkan perubahan yang optimal tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan praktik diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Kombinasi dari berbagai strategi pelatihan akan meningkatkan efektivitas intervensi, sekaligus memperkuat daya tahan dan keberlanjutannya di lapangan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan:

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pendekatan yang berfokus pada pencapaian keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Pendekatan ini tidak hanya menargetkan peningkatan

pengetahuan secara teoritis, tetapi juga menekankan pentingnya penguasaan keterampilan klinis yang relevan dengan tugas sehari-hari tenaga kesehatan, dalam hal ini bidan. Dalam konteks skrining kesehatan mental perinatal, keterampilan seperti komunikasi empatik, penggunaan alat skrining, serta interpretasi hasil menjadi komponen penting yang harus dikuasai secara langsung. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam pelatihan berbasis kompetensi adalah simulasi klinis. Melalui simulasi, peserta pelatihan dihadapkan pada skenario yang menyerupai kondisi nyata di lapangan, termasuk menghadapi ibu hamil dengan gejala-gejala awal gangguan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga melatih sensitivitas dan ketepatan respons bidan dalam situasi yang penuh nuansa emosional dan psikososial. (Piot et al., 2021)

Selain itu, metode studi kasus juga menjadi bagian integral dari pelatihan jenis ini. Studi kasus memungkinkan peserta menganalisis situasi secara mendalam, menilai pilihan intervensi, serta mendiskusikan kemungkinan konsekuensi dari berbagai keputusan klinis yang diambil. Hal ini sangat penting karena dalam praktik sehari-hari, bidan sering kali harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat, berdasarkan pertimbangan multidimensional yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga sosial dan psikologis.

Sebagai pelengkap dari dua pendekatan tersebut, penggunaan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) telah terbukti sebagai alat evaluasi yang efektif untuk menilai pencapaian kompetensi klinis secara objektif dan sistematis. Dalam konteks pendidikan kebidanan, OSCE

memungkinkan instruktur untuk mengamati langsung performa peserta dalam menjalankan prosedur atau skenario klinis, termasuk proses skrining kesehatan mental. Studi menunjukkan bahwa penerapan OSCE tidak hanya meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka dalam melakukan interaksi langsung dengan pasien. Mahasiswa kebidanan yang mengikuti OSCE secara rutin melaporkan peningkatan kemampuan dalam menjalin komunikasi terapeutik dan mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan mental perinatal.

Lebih jauh, pelatihan yang menekankan pada pengalaman langsung melalui simulasi dan OSCE memberikan peluang bagi peserta untuk melakukan refleksi diri, mengenali kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, serta menerima umpan balik yang membangun dari fasilitator. Proses pembelajaran ini menjadi sangat berharga karena memungkinkan terjadinya *deep learning*—pembelajaran yang tidak hanya menghafal informasi, tetapi benar-benar memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip yang dibutuhkan dalam praktik profesional.

Dengan demikian, pelatihan berbasis kompetensi yang menggabungkan metode simulasi klinis, studi kasus, dan OSCE bukan hanya mampu meningkatkan keterampilan teknis bidan, tetapi juga membentuk sikap profesional, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat pemahaman akan pentingnya peran mereka dalam menjaga kesehatan mental ibu selama masa perinatal.

2. Pendampingan atau Mentoring Klinis

Pendampingan oleh mentor yang berpengalaman selama pelatihan klinis memegang peran strategis dalam membantu bidan mengintegrasikan pengetahuan teoritis ke dalam praktik nyata. Melalui proses mentoring yang terstruktur, bidan tidak hanya mendapatkan bimbingan teknis dalam situasi klinis, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan refleksi kritis terhadap tindakan klinis yang dilakukan. Keberadaan mentor memberikan ruang untuk umpan balik yang konstruktif serta memperkuat rasa percaya diri dan kompetensi profesional peserta. Berbagai studi menunjukkan bahwa program pendampingan klinis dapat meningkatkan keterampilan, sikap, dan kesiapan praktik mahasiswa kebidanan secara signifikan, khususnya dalam konteks pelayanan yang kompleks seperti skrining kesehatan mental perinatal. Selain itu, interaksi langsung dengan mentor juga membentuk nilai-nilai etika dan empati yang krusial dalam pelayanan kebidanan yang humanistik. (Stefaniak & Dmoch-Gajzlerska, 2020)

BAB 5

Penutup

Pengetahuan bidan tentang skrining kesehatan mental perinatal pada kelompok intervensi menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah diberikan pelatihan (*p value* 0,001), sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan pengetahuan (*p value* 0,873). Skor rata-rata pengetahuan bidan pada kelompok intervensi setelah intervensi lebih tinggi (Mean $\pm$ SD 8,50 $\pm$ 1,04) dibandingkan kelompok kontrol (Mean $\pm$ SD 6,67 $\pm$ 1,34). Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan intervensi pelatihan, terdapat peningkatan pengetahuan yang signifikan pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Sikap bidan terhadap pelaksanaan skrining kesehatan mental perinatal baik pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol terbukti tidak terdapat perbedaan yang signifikan setelah diberikan pelatihan. Pada kelompok intervensi, *p value* sebesar 0,419, sedangkan pada kelompok kontrol 0,480. Meskipun secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan, skor rata-rata sikap bidan terhadap pelaksanaan skrining PMH pada kelompok intervensi setelah intervensi lebih tinggi (Mean $\pm$ SD 8,47 $\pm$ 0,86) dibandingkan kelompok kontrol (Mean $\pm$ SD 7,50 $\pm$ 2,16).

Praktik bidan dalam melakukan skrining perinatal mental health (PMH) pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah diberikan intervensi. Pada kelompok intervensi p value sebesar 0,001, sedangkan pada kelompok kontrol 0,002. Meskipun kedua kelompok menunjukkan adanya peningkatan praktik, skor rata-rata praktik bidan dalam melakukan skrining PMH pada kelompok intervensi setelah intervensi lebih tinggi (Mean $\pm$ SD 12,30 $\pm$ 1,87) dibandingkan kelompok kontrol (Mean $\pm$ SD 10,67 $\pm$ 3,02).

Hasil analisis biserial menunjukkan bahwa di antara variabel pengetahuan, sikap, dan praktik bidan dalam skrining kesehatan mental perinatal, hanya pengetahuan yang memiliki hubungan signifikan secara statistik dengan pelaksanaan skrining. Hal ini terlihat dari nilai korelasi biserial pengetahuan sebesar 0.489 dengan p-value 0.001, yang menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan. Sementara itu, sikap memiliki korelasi biserial 0.257 dengan p-value 0.005, menunjukkan hubungan yang signifikan namun lebih lemah. Praktik bidan, dengan nilai korelasi biserial 0.163 dan p-value 0.075, tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan bidan lebih berdampak dalam mendorong pelaksanaan skrining perinatal dibandingkan sikap dan praktik mereka.

Daftar Pustaka

- Adrian Covaci. (2020). *How can airborne transmission of COVID-19 indoors be minimised. January.*
- Agnes Higgins, Carmel Downes, Mark Monahan, & Aillish Gill. (2018). Barriers to midwives and nurses addressing mental health issues with women: The Mind Mothers study. *Journal of Clinical Nursing*, 27(9–10), 1872–1883. <https://doi.org/10.1111/jocn.14252>
- Ali Mustofa, Ainun Nandya Hapsari, Alya Nabila, Ajeng Kalishyah Putri, Nursyta, A. M., & Era Catur Prsetya. (2021). Faktor Resiko Depresi Pasca Persalinan Negara Asia Tenggara. *Medica Arteriana*, 3 No 2. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MedArt/article/view/8470/pdf>
- Ana Pujianti Harahap, Rizkia Amilia, Aulia Amini, Indriani Makmun, & Cahaya Indah Lestari. (2022). *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui* (Muhammad Husein Maruapey (ed.); 1st ed.). KBM Indonesia.
- Badiya, P. K., Siddabattuni, S., Dey, D., Javvaji, S. K., Nayak, S. P., Hiremath, A. C., Upadhyaya, R., Madras, L., Nalam, R. L., Prabhakar, Y., Vaitheswaran, S., Manjjuri, A. R., JK, K. K., Subramaniyan, M., Raghunatha Sarma, R., & Ramamurthy, S. S. (2020). Identification of clinical and psychosocial characteristics associated with perinatal depression in the south Indian population. *General Hospital Psychiatry*, 66(August), 161–170. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2020.08.002>
- Baker, N., Gillman, L., & Kirstie Coxon. (2020). Assessing mental health during pregnancy: An exploratory qualitative study of midwives' perceptions. *Midwifery Journal*, 86. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102690>
- Bante, A., Mersha, A., Zerdo, Z., Wassihun, B., & Yeheyis, T. (2021a). Comorbid anxiety and depression: Prevalence and associated factors among pregnant women in Arba Minch zuria district, Gamo zone, southern Ethiopia. *PloS One*, 16(3), e0248331. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248331>
- Bante, A., Mersha, A., Zerdo, Z., Wassihun, B., & Yeheyis, T. (2021b). Comorbid anxiety and depression: Prevalence and associated

- factors among pregnant women in Arba Minch zuria district, Gamo zone, southern Ethiopia. *PLoS ONE*, 16(3 March), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248331>
- Branquinho, M., Shakeel, N., Horsch, A., & Fonseca, A. (2022). Frontline health professionals' perinatal depression literacy: A systematic review. *Midwifery*, 111, 103365. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103365>
- Cantwell, R. (2021). Mental disorder in pregnancy and the early postpartum. *Anaesthesia*, 76(54), 76–83. <https://doi.org/10.1111/anae.15424>
- Cena, L., Palumbo, G., Mirabella, F., Gigantesco, A., Stefana, A., Trainini, A., Tralli, N., & Imbasciati, A. (2020). Perspectives on Early Screening and Prompt Intervention to Identify and Treat Maternal Perinatal Mental Health. Protocol for a Prospective Multicenter Study in Italy. *Frontiers in Psychology*, 11(March), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00365>
- Comrie-Thomson, L., Webb, K., Patel, D., Wata, P., Kapamurandu, Z., Mushavi, A., Nicholas, M. A., Agius, P. A., Davis, J., & Luchters, S. (2022). Engaging women and men in the gendersynchronised, community-based Mbereko+Men intervention to improve maternal mental health and perinatal care-seeking in Manicaland, Zimbabwe: A cluster-randomised controlled pragmatic trial. *Journal of Global Health*, 12. <https://doi.org/10.7189/JOGH.12.04042>
- Daehn, D., Rudolf, S., Pawils, S., & Renneberg, B. (2022). Perinatal mental health literacy: knowledge, attitudes, and help-seeking among perinatal women and the public – a systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04865-y>
- Dazzan, P., Fusté, M., & Davies, W. (2018). Do Defective Immune System-Mediated Myelination Processes Increase Postpartum Psychosis Risk? *Trends in Molecular Medicine*, 24(11), 942–949. <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2018.09.002>
- de Avilla, J. C., Giugliani, C., Leria Bizon, A. M. B., Magnus Martins, A. C., Kroll de Senna, A. F., & Justo Giugliani, E. R. (2020). Association between maternal satisfaction with breastfeeding and postpartum depression symptoms. *PLoS ONE*, 15(11 November), 1–10. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242333>

- Dennis, C. L., Falah-Hassani, K., & Shiri, R. (2017). Prevalence of antenatal and postnatal anxiety: Systematic review and meta-analysis. *British Journal of Psychiatry*, 210(5), 315–323. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.187179>
- Deti Siti Nurdianti. (2020). *Kental manis kesehatan mental*.
- Dian, C. N., Effendy, E., & Amin, M. M. (2022). The Validation of Indonesian Version of Patient Health Questionnaire-9. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(T7), 193–198. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.9293>
- Dyer, E., Bell, R., Graham, R., & Rankin, J. (2019). Pregnancy decisions after fetal or perinatal death: systematic review of qualitative research. *BMJ Open*, 9(12), 27–29. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029930>
- Elena Ali. (2023). Women's experiences with postpartum anxiety disorders: a narrative literature review. *International Journal of Women's Health*. <https://doi.org/DOI> <https://doi.org/10.2147/IJWH.S158621>
- Elisabeth Hertenstein Bernd Feige, Gmeiner, T., Kienzler, C., Spiegelhalder, K., Johann, A., Palagini, M. J.-F. L., Rücker, G., Riemann, D., & Chiara Baglioni. (2019). Insomnia as a predictor of mental disorders: A systematic review and meta-analysis. *Elsevier*. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.10.006>
- Emily J Fawcett, Fairbrother, N., Cox, M. L., White, I. R., & Jonathan M Fawcett. (2019). The Prevalence of Anxiety Disorders During Pregnancy and the Postpartum Period: A Multivariate Bayesian Meta-Analysis. *Europe PMC Funders Group*. <https://doi.org/10.4088/JCP.18r12527>
- Erna Veronika. (2023). *Skrining*.
- Garman, E. C., Schneider, M., & Lund, C. (2019). Perinatal depressive symptoms among low-income South African women at risk of depression: trajectories and predictors. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), 202. <https://doi.org/10.1186/s12884-019-2355-y>
- Gimeno Garca, A. Z. (2012). Factors influencing colorectal cancer screening participation. *Gastroenterology Research and Practice*, 2012. <https://doi.org/10.1155/2012/483417>
- Gureje, O., Oladeji, B. D., Araya, R., Montgomery, A. A., Kola, L., Kirmayer,

- L., Zelkowitz, P., & Groleau, D. (2015). Expanding care for perinatal women with depression (EXPONATE): Study protocol for a randomized controlled trial of an intervention package for perinatal depression in primary care. *BMC Psychiatry*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12888-015-0537-3>
- Hantsoo, L., Criniti, S., Khan, A., Moseley, M., Kincler, N., Faherty, L. J., & Ian M. BennetEpperson, C. N. (2018). Mobile application for monitoring and management of depressed mood in a vulnerable pregnant population. *Psychiatr Serv*, 176(1). <https://doi.org/10.1007/s00737-018-0895-1>
- Herri Zan Pieter, & Namora Lumongga Lubis. (2014). *Pengantar Psikologi Kebidanan* (Revisi). Prenamedia Grup.
- Howard, L. M., & Khalifeh, H. (2020). Perinatal mental health: a review of progress and challenges. *World Psychiatry*, 19(3), 313–327. <https://doi.org/10.1002/wps.20769>
- Hübner, T., Wolfgang, T., Theis, A. C., Steber, M., Wiedenmann, L., Wöckel, A., Diessner, J., Hein, G., Gründahl, M., Kämmerer, U., Kittel-Schneider, S., & Bartmann, C. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on stress and other psychological factors in pregnant women giving birth during the first wave of the pandemic. *Reproductive Health*, 19(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12978-022-01493-9>
- Hunna J Watson Stephanie Zerwas, Torgersen, L., Diemer, K. G. E. W., & Gun Peggy Knudsen 2, Ted Reichborn-Kjennerud 4, C. M. B. 5. (2017). Maternal eating disorders and perinatal outcomes: A three-generation study in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. *Journal Abnorm Psychology*. <https://doi.org/10.1037/abn0000241>
- I Wayan Gede Artawan Eka Putra, I Made Sutarga, Kardiniwata, M. P., Suariyani, N. P. L., Septarini, N. W., & I Made Subrata. (2016). *Modul Penelitian Uji Diagnostik dan Skrining*. Fakultas Kedokteran Udayana.
- Islam, M. J., Broidy, L., Baird, K., & Mazerolle, P. (2017). Intimate partner violence around the time of pregnancy and postpartum depression: The experience of women of Bangladesh. *PLoS ONE*, 12(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176211>
- Janice H Goodman, Chenausky, L. K., Freeman, & Marlene P. (2014).

- Anxiety disorders during pregnancy: a systematic review. *The Journal of Clinical Psychiatry*. <https://doi.org/10.4088/JCP.14r09035>.
- Jordan, P., Shedden-Mora, M. C., & Löwe, B. (2017). Psychometric analysis of the Generalized Anxiety Disorder scale (GAD-7) in primary care using modern item response theory. *PLoS ONE*, 12(8), 1–14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182162>
- Kelompok Studi Immunodermatologi Indonesia. (2016). *Psychoneuroimmunology in dermatology*. Fakultas Kedokteran Udayana.
- Kemenkes. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi COVID-19*.
- Kemenkes RI. (2018). *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*.
- Kemenkes RI. (2019). *Bagan Tata Laksana Kasus Terpadu Pelayanan Pasca Persalinan*.
- Kemenkes RI. (2021). *Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa*.
- Kingston, D., McDonald, S., Tough, S., Austin, M. P., Hegadoren, K., & Lasiuk, G. (2014). Public views of acceptability of perinatal mental health screening and treatment preference: A population based survey. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-67>
- Layliana, & Septi Indah Permata Sari. (2021). *Modul Pelatihan Penggunaan Edinburg Postnatal Depression scale (EPDS) sebagai alat deteksi dini depression postpartum bagi bidan* (Natika (ed.)).
- Leila Nisya Ayuanda, Wahidin, W., Raidanti, D., Minarti, M., & Ningsih, D. A. (2022). Online Midwife's Training on Psychoeducation of Perinatal Mental Health During COVID-19 Pandemic. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 6 no 1, 85–87. <https://doi.org/10.53730/ijssh.v6n1.4741>
- Lindayani, I. K., & Marhaeni, G. A. (2019). Prevalensi Dan Faktor Risiko Depresi Post Partum di Kota Denpasar Tahun 2019. *Jurnal Midwifery Update*, 8511, 100–109.
- Lois, M., Martinez, L., Machado, De, S. T., Eden, A., Stoodley, C., & Pam Adelson. (2024). Evaluation of a pilot online education program to develop midwives' knowledge, skill and confidence in perinatal

- mental health in rural South Australia. *Women and Birth*, 37(2), 355–361.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2023.11.005>
- MacMillan, K. K., Lewis, A. J., Watson, S. J., & Galbally, M. (2020). Maternal depression and the emotional availability of mothers at six months postpartum: Findings from the Mercy Pregnancy and Emotional Wellbeing Study (MPEWS) pregnancy cohort. *Journal of Affective Disorders*, 266(September 2019), 678–685.
<https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.109>
- Maisyarah, Salman, Efendi Sianturi, & Dyah WidodoGanif Djuandi. (2021). *Dasar Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesehatan* (Janner Simmarmata (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Maralyn Foureur. (2019). The role and competence of midwives in supporting women with mental health concerns during the perinatal period: A scoping review. *Health & Social Care in the Community*, 27(4), 389–405.
<https://doi.org/doi.org/10.1111/hsc.12740>
- Margaret Carroll, Downes, C., Gill, A., & Monahan, M. (2018). Knowledge, confidence, skills and practices among Midwives in the Republic of Ireland in relation to perinatal mental health care: The Mind Mothers study. *Midwifery Journal*.
<https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.05.006>
- Maria, T., Lykeridou Katerina, & DimitraMetallinou. (2023). The Value of Simulation-Based Training in Midwifery. *Journal of Nursing and Midwifery*, 5(3), 40–43.
<https://doi.org/10.36349/easjnm.2023.v05i03.001>
- Marie Hastings-Tolsma Annie Temane, Lukhele, O. B. T. S., & Nolte, A. G. (2021). Experience of midwives in providing care to labouring women in varied healthcare settings: A qualitative study. *AOSIS*.
<https://doi.org/10.4102/hsag.v26i0.1524>
- Marine Dubreucq, Corinne Dupont, Mijke P. Lambregtse-Van den Berg, Wichor M. Bramer, Catherine Massoubre, & Julien Dubreucq. (2023). A systematic review of midwives' training needs in perinatal mental health and related interventions. *Frontiers in Psychiatry*, 15–2024. <https://doi.org/doi.org/10.3389/fpsy.2024.1345738>
- McCauley, K., Muir-Cochrane, S. E. E., & Lyneham, J. (2011). Midwives and

- assessment of perinatal mental health. *Psychiatr Ment Health Nurs*, 18 (9). <https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2011.01727.x>
- Minh Thi Hong Le^{1*}, Thach Duc Tran¹, Sara Holton¹, Huong Thanh Nguyen², Rory Wolfe³, J. F. (2020). Reliability, convergent validity and factor structure of the DASS-21 in a sample of Vietnamese adolescents. *Journal of Affective Disorders*, 277(1), 110456. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.08>
- Nguyen, K., Mukona, L. T., Nalbandyan, L., Yar, N., St Fleur, G., Mukona, L., Hernandez, E., & Lamberty, N. (2022). Peripartum Complications as Risk Factors for Postpartum Psychosis: A Systemic Review. *Cureus*, 14(9), e29224. <https://doi.org/10.7759/cureus.29224>
- Nithianandan, N., Gibson-Helm, M., McBride, J., Binny, A., Gray, K. M., East, C., & Boyle, J. A. (2016). Factors affecting implementation of perinatal mental health screening in women of refugee background. *Implementation Science*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s13012-016-0515-2>
- Noonan, M., Jomeen, J., Rose Galvin, & Doody, O. (2018). Survey of midwives' perinatal mental health knowledge, confidence, attitudes and learning needs. *Women and Birth*, 31(6), e358–e366. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.wombi.2018.02.002>
- Novisari, L., & Kemala, C. N. (2021). Penerapan Acceptance and Commitment Therapy (ACT) pada Siswi Perempuan di Masa COVID-19. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 6(2), 125–147. <https://doi.org/10.24176/perseptual.v6i2.6137>
- Nwoke, C. N., Awosoga, O. A., McDonald, S., Bonifacio, G. T., & Leung, B. M. Y. (2023). African Immigrant Mothers' Views of Perinatal Mental Health and Acceptability of Perinatal Mental Health Screening: Quantitative Cross-sectional Survey Study. *JMIR Formative Research*, 7. <https://doi.org/10.2196/40008>
- O'Hara, M. W., & Wisner, K. L. (2014). Perinatal mental illness: Definition, description and aetiology. *Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology*, 28(1), 3–12. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2013.09.002>
- Pawluski, J. L., Lonstein, J. S., & Fleming³, A. S. (2017). The Neurobiology of Postpartum Anxiety and Depression. *Cell Press*. <https://sci-hub.se/10.1016/j.tins.2016.11.009>

- Peng, S., Lai, X., Du, Y., Meng, L., Gan, Y., & Zhang, X. (2021). Prevalence and risk factors of postpartum depression in China: A hospital-based cross-sectional study. *Journal of Affective Disorders*, 282(December 2020), 1096–1100. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.01.012>
- Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. (2021). *Updating Asuhan Nifas dan Pelayanan Kontrasepsi*.
- Percudani, M., Bramante, A., Brenna, V., & Pariante, C. (2022). Key topics in perinatal mental health. In *Key Topics in Perinatal Mental Health*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-91832-3>
- Pilav, S., De Backer, K., Easter, A., Silverio, S. A., Sundaresh, S., Roberts, S., & Howard, L. M. (2022). A qualitative study of minority ethnic women's experiences of access to and engagement with perinatal mental health care. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04698-9>
- Piot, M. A., Dechartres, A., & Chris Attoe. (2021). Effectiveness of simulation in psychiatry for nursing students, nurses and nurse practitioners: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 78(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jan.14986>
- Premji, S. S., Dobson, K. S., Prashad, A., Yamamoto, S., Tao, F., Zhu, B., Wu, X., Lu, M., & Shao, S. (2021). What stakeholders think: perceptions of perinatal depression and screening in China's primary care system. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-03473-y>
- Price, D. A. M., Middleton, M. M., Matthey, A. A. P. S. A. A. P. S., Goldfeld, P. S., Kemp, P. L., & Orsini, M. F. (2021). A comparison of two measures to screen for mental health symptoms in pregnancy and early postpartum: the Matthey Generic Mood Questionnaire and the Depression, Anxiety, Stress Scales short-form. *Journal of Affective Disorders*, 281(October 2020), 824–833. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.11.055>
- Purnama, G. S. (2017). Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan. In *Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana*. Yayasan Kita Menulis.
- Riduwan. (2013). *Dasar-dasar statistik* (2nd ed.). Alfabeta.

<https://lib.atim.ac.id/opac/detail-opac?id=443>

- Rohani Rohani, & Cesa Septiana Pratiwi. (2024). Midwives' Role in Managing Pregnant Women with Mental Health Issues and Disorders in Developing Countries: A Rapid Review. *Poltekita Jurnal Ilmu Kesehatan*, 17. <https://doi.org/doi.org/10.33860/jik.v17i4.3570>
- Roubinov, D., Browne, D., LeWinn, K. Z., Lisha, N., Mason, W. A., & Bush, N. R. (2022). Intergenerational transmission of maternal childhood adversity and depression on children's internalizing problems. *Journal of Affective Disorders*, 308(July 2021), 205–212. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.04.030>
- Rusdi Maslim. (2019). *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa* (3rd ed.). Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya.
- Saba Mughal; Yusra Azhar; Waquar Siddiqui. (2022). Postpartum Depression. *National Center for Biotechnology Information*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519070/>
- Sadat, Z., Abedzadeh Kalahroudi, M., Kafaei Atrian, M., Karimian, Z., & Sooki, Z. (2014). The impact of postpartum depression on quality of life in women after child's birth. *Iranian Red Crescent Medical Journal*, 16(2). <https://doi.org/10.5812/ircmj.14995>
- Sandy, W. F., Dasuki, D., Hayati, E. N., & Suhariyanto, S. (2020). Domestic Violence and Postpartum Depression. *Jurnal Ners*, 15(2), 135–141. <https://doi.org/10.20473/jn.v15i2.16930>
- Sapra, A., Bhandari, P., Sharma, S., Chanpura, T., & Lopp, L. (2020). Using Generalized Anxiety Disorder-2 (GAD-2) and GAD-7 in a Primary Care Setting. *Cureus*, 2(5). <https://doi.org/10.7759/cureus.8224>
- Simcock, G., Kildea, S., Kruske, S., Laplante, D. P., Elgbeili, G., & King, S. (2018). Disaster in pregnancy: Midwifery continuity positively impacts infant neurodevelopment, QF2011 study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 18(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12884-018-1944-5>
- Soekidjo Notoamtmodjo. (2020). *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Kedua). PT Rineka Cipta.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. PT Rineka Cipta.
- Soep. (2011). Edinburgh post-partum depression scale. *Jurusan*

Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan, Sumatera Barat 20136, Indonesia, 14, 95–100.

- Stefaniak, M., & Dmoch-Gajzlerska, E. (2020). Mentoring in the clinical training of midwifery students - a focus study of the experiences and opinions of midwifery students at the Medical University of Warsaw participating in a mentoring program. *BMC Medical Education, 20*(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02324-w>
- Stevenson, A. A., Bauman, B. L., Zapata, L. B., Ahluwalia, I. B., & Tepper, N. K. (2020). Intimate Partner Violence around the Time of Pregnancy and Postpartum Contraceptive Use. *Women's Health Issues, 30*(2), 98–105. <https://doi.org/10.1016/j.whi.2019.11.006>
- Sugeng, I. L. (2013). Kadar oksitosin dan bendungan asi pada ibu primipara dengan. *Jurnal Ners, 8*(1), 1–8.
- Treasure, J., Duarte, T. A., & Ulrike Schmidt. (2020). Eating disorders. *Lancet*. [https://doi.org/D10.1016/S0140-6736\(20\)30059-3](https://doi.org/D10.1016/S0140-6736(20)30059-3)
- Van Niel, M. S., & Payne, J. L. (2020). Perinatal depression: A review. *Cleveland Clinic Journal of Medicine, 87*(5), 273–277. <https://doi.org/10.3949/ccjm.87a.19054>
- van Steijn, M. E., Scheepstra, K. W. F., Zaat, T. R., van Rooijen, D. E., Stramrood, C. A. I., Dijkman, L. M., Valkenburg-van den Berg, A. W., Wiltenburg, W., van der Post, J. A. M., Olff, M., & van Pampus, M. G. (2021). Severe postpartum hemorrhage increases risk of posttraumatic stress disorder: a prospective cohort study. *Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 42*(4), 335–345. <https://doi.org/10.1080/0167482X.2020.1735343>
- Veerle Bergink. (2012). First-onset Postpartum Psychosis. In *Onderzoeksprogramma Postpartum Psychose Erasmus MC Rotterdam*. file:///C:/Users/USER/Downloads/121031_Bergink, Veerle.pdf
- Vijayalakshmi Poreddi Sailaxmi Gandhi Ramachandra, Desai, S. G. G., & Chandra2, P. S. (2023). Evaluation of a manual-based training program in changing auxiliary nurse midwives (ANMs) knowledge, attitudes, and skills related to maternal mental health. *Indian Journal of Psychiatry*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10358814/>

- Vrublevska, J., Trapencieris, M., & Rancans, E. (2018). Adaptation and validation of the Patient Health Questionnaire-9 to evaluate major depression in a primary care sample in Latvia. *Nordic Journal of Psychiatry*, 72(2), 112–118. <https://doi.org/10.1080/08039488.2017.1397191>
- Wang, T.-H., Tzeng, Y.-L., Teng, Y.-K., Pai, L.-W., & Tzu-Pei Yeh. (2021). Evaluation of psychological training for nurses and midwives to optimise care for women with perinatal depression: a systematic review and meta-analysis. *Midwifery Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103160>
- WHO. (2022). *Guide for integration of perinatal mental health in maternal and child health services*.
- WHO. (2024a). *Midwifery education and care*. Maternal Health Unit.
- WHO. (2024b). *Strengthening the skills of future midwives*. <https://www.who.int/azerbaijan/news/item/03-05-2024-strengthening-the-skills-of-future-midwives>
- World Health Organization. (2017). mhGAP training manuals for the mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings version 2.0. *Who/Msd/Mer/17.6, 0*, 1–656.
- Yonemoto, N., Nagai, S., & Mori, R. (2021). Schedules for home visits in the early postpartum period. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 7(7), CD009326. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009326.pub4>
- Zhang, S., Wang, L., Yang, T., Chen, L., Qiu, X., Wang, T., Chen, L., Zhao, L., Ye, Z., Zheng, Z., & Qin, J. (2019). Maternal violence experiences and risk of postpartum depression: A meta-analysis of cohort studies. *European Psychiatry*, 55, 90–101. <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2018.10.005>

Profil Penulis



Dr. Ana Pujianti Harahap, S.Si.T., M.Keb.

Lahir di Montong Baan, 10 September 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Diploma III Kebidanan, Universitas Ngudi Waluyo Ungaran Semarang lulus tahun 2008, dan langsung melanjutkan program studi D IV Bidan Pendidik di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran Semarang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun 2017. Di tahun 2022 melanjutkan Program Studi Doktoral (S3) Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro peminatan Kesehatan Ibu dan Anak lulus tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 sebagai bidan di Rumah Islam Siti Hajar Kota Mataram sampai dengan tahun 2012. Selanjutnya di Tahun 2012 s/d saat ini penulis aktif bekerja di Universitas Muhammadiyah Mataram mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II Bidang AIK dan Kemahasiswaan tahun 2017-2021. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi masyarakat yaitu sebagai Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Mataram Prov. NTB dalam Divisi Pendidikan tahun 2019-2024. Selain itu pernah sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang Aisyiyah Labuapi Lombok barat periode 2020-2024. Penulis juga aktif sebagai reviewer jurnal nasional maupun internasional tahun 2023-2025.

Penulis dapat dihubungi melalui
e-mail ana.harahap87@gmail.com

Profil Penulis



Aulia Amini, S.ST., M. Keb lahir di Sumbawa tanggal 14 bulan Juni tahun 1989. Penulis memperoleh gelar ahli madya kebidanan (Amd. Keb) pada tahun 2010 di Universitas Muhammadiyah Mataram, kemudian melanjutkan Pendidikan DIV di Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2013. Tahun 2015, penulis melanjutkan studi S2 Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2017. Penulis bekerja di Program studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram (FIK UMMAT) sejak tahun 2011 hingga sekarang, dan saat ini penulis menjabat sebagai ketua program studi. Penulis aktif di organisasi masyarakat sebagai Sekertaris di Pengurus Pimpinan Aisyiyah Prov. NTB tahun 2022-2027. Selain itu sebagai pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Aisyiyah Muhammadiyah Indonesia tahun 2023-2027 pada Divisi Riset dan Publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui auliaamini1406@gmail.com

Profil Penulis



Cahaya Indah Lestari, SST., M.Keb.

Lahir di Mataram 17 Maret 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 dan D4 di Poltekes Kemenkes Mataram tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai Dosen Kebidanan sampai dengan saat ini. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Keuangan tahun 2021-2025. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi masyarakat yaitu sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Mataram Prov NTB. Selain sebagai pengajar penulis juga aktif dalam berbagai seminar dan kegiatan karya ilmiah lainnya.

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas secara komprehensif efektivitas pelatihan skrining kesehatan mental perinatal (Perinatal Mental Health/PMH) bagi bidan di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik mereka. Kesehatan mental pada ibu hamil dan pascapersalinan, termasuk gangguan seperti depresi dan kecemasan, memiliki dampak serius pada ibu dan bayi. Tingginya prevalensi gangguan kesehatan mental perinatal di Indonesia, yang berkisar antara 50% hingga 75%, memperlihatkan pentingnya deteksi dini melalui skrining yang dilakukan oleh bidan.

Dalam buku ini, diuraikan berbagai tantangan yang dihadapi bidan dalam melakukan skrining PMH, mulai dari keterbatasan pengetahuan hingga sikap yang belum optimal. Studi yang dibahas dalam buku ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan bidan, dampak terhadap sikap dan praktik dalam melaksanakan skrining kesehatan mental perinatal masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Buku ini menggunakan pendekatan statistik seperti uji *Wilcoxon*, *Mann-Whitney*, dan korelasi biserial untuk menganalisis efektivitas pelatihan tersebut. Penulis juga mengevaluasi hambatan dalam perubahan sikap dan praktik bidan serta menawarkan rekomendasi untuk strategi pelatihan yang lebih efektif. Dengan analisis yang mendalam, buku ini memberikan kontribusi empiris penting dalam konteks implementasi skrining kesehatan mental perinatal di Indonesia.

Ditujukan bagi peneliti, tenaga kesehatan, dan pemangku kebijakan, buku ini menjadi referensi penting dalam upaya meningkatkan kualitas skrining gangguan kesehatan mental perinatal dan mengembangkan program pelatihan yang lebih komprehensif guna mendukung peran bidan dalam mendeteksi dan menangani masalah kesehatan mental perinatal.

Buku ini membahas secara komprehensif efektivitas pelatihan skrining kesehatan mental perinatal (Perinatal Mental Health/PMH) bagi bidan di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik mereka. Kesehatan mental pada ibu hamil dan pascapersalinan, termasuk gangguan seperti depresi dan kecemasan, memiliki dampak serius pada ibu dan bayi. Tingginya prevalensi gangguan kesehatan mental perinatal di Indonesia, yang berkisar antara 50% hingga 75%, memperlihatkan pentingnya deteksi dini melalui skrining yang dilakukan oleh bidan.

Dalam buku ini, diuraikan berbagai tantangan yang dihadapi bidan dalam melakukan skrining PMH, mulai dari keterbatasan pengetahuan hingga sikap yang belum optimal. Studi yang dibahas dalam buku ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan bidan, dampak terhadap sikap dan praktik dalam melaksanakan skrining kesehatan mental perinatal masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Buku ini menggunakan pendekatan statistik seperti uji Wilcoxon, Mann-Whitney, dan korelasi biserial untuk menganalisis efektivitas pelatihan tersebut. Penulis juga mengevaluasi hambatan dalam perubahan sikap dan praktik bidan serta menawarkan rekomendasi untuk strategi pelatihan yang lebih efektif. Dengan analisis yang mendalam, buku ini memberikan kontribusi empiris penting dalam konteks implementasi skrining kesehatan mental perinatal di Indonesia.

Ditujukan bagi peneliti, tenaga kesehatan, dan pemangku kebijakan, buku ini menjadi referensi penting dalam upaya meningkatkan kualitas skrining gangguan kesehatan mental perinatal dan mengembangkan program pelatihan yang lebih komprehensif guna mendukung peran bidan dalam mendeteksi dan menangani masalah kesehatan mental perinatal.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89965-5-1



9

786238

996551